Terminología Mínima Estándar en Endoscopia Digestiva©

Editor Internacional: Michel Delvaux

Editor ASGE: Louis Y. Korman

Posición: Versión 2.0h Fecha: 9 de Marzo de 1999.

Procedencia: Joint Committee For Minimal Standard Terminology of ESGE, ASGE, OMED.

Versión en castellano por los Dres. J. R. Armengol-Miró y J. Boix-Vallverde. Barcelona.

Copyright (Derechos de autor) y Términos de uso

Copyright 1995 Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE). Reservados los derechos.

Esta frase debe mostrarse en cada copia del MST, en todos los manuales y otro material utilizado en relación con el MST, incluyendo medios electrónicos (disquetes, CD-ROM, etc.) y debe estar visible en los ficheros de textos cargados en los disquetes o en el Internet. El permiso se concede por este medio, sin acuerdo escrito y sin licencia de honorarios, para utilizarlo, copiarlo o distribuir el Minimal Standard Terminology (MST) para cualquier propósito.

La intención del MST no es la de definir la realización de bases de datos sino suministrar una terminología estándar para usarla por la comunidad endoscópica en la creación de los informes de endoscopía.
Los usuarios del MST están de acuerdo con las siguientes condiciones:

Incluirán avisos de los derechos de autor y términos de uso en cualquier copia de la base de datos MST que se distribuya.
No cambiarán ningún contenido en los campos MST definidos. Los usuarios pueden añadir sus propios campos en la base de datos si desean adjuntar información adicional a la ya existente en el MST. Si se añaden nuevas grabaciones en el MST para ser conformes con los requisitos locales, estas grabaciones deben ser identificadas por separado de lo del MST. Este mecanismo de identificación facilita el intercambio de información sin crear términos superfluos.

La ESGE y los miembros del Comité de Mínimos Estándar de la ESGE no aceptan la responsabilidad por cualquier omisión o error en el MST y todas las AUTORIZACIONES EXPLÍCITAS o IMPLÍCITAS INCLUYENDO AQUELLAS ACERCA DE LA COMERCIALIZACIÓN o CONVENIENCIA DE UN PROPOSITO DETERMINADO , SON RECHAZADAS.

Esta Publicación de la Minimal Standard Terminology in Digestive Endoscopy (M.S.T.), en traducción castellana de los Dres. J. R. Armengol - Miró y J. Boix - Vallverde, fue realizada por el Comité de Terminología Endoscópica Digestiva de la Federación de Asociaciones Argentinas de Endoscopía Digestiva (A.A.E.D.) con la colaboración de los Laboratorios Roemmers.
General Pico - La Pampa -Argentina - Septiembre 2005

Indice

Comité de Terminología Endoscópica Digestiva de A.A.E.D. 5

Prólogo del Prof. Dr. Eduardo G. Segal 6
Profesor Asociado de Gastroenterología / Vice Presidente de O.M.E.D.

Prólogo del Dr. Víctor Hugo Albizzatti 7
Presidente de la Federación de Asociaciones Argentinas de Endoscopía Digestiva {AAED)

Prólogo de esta Edición 8
Dr. Rubén Eduardo Lettieri - Coordinador Comité de Terminología Endoscópica Digestiva de AAED

Presentación 9
Dr. Rubén Eduardo Lettieri - Coordinador Comité de Terminología Endoscópica Digestiva de AAED

Lista de Tablas 11

Definiciones, Símbolos y Abreviaciones 12

1-Avance 13

2-Introducción 13

2-1-ORGANIZACIÓN GENERAL 15
2-2-DECISIONES SOBRE TÉRMINOS DIFÍCILES 15
2-2-1-Estenosis 15
2-2-2-Mucosa roja, eritema, mucosa congestiva, hiperemia 16
2-2-3-Mucosa esclerosada 16
2-2-4-Erosión, afta 16
2-2-5-Tumor, masa 16
2-2-6-Angiectasia 16
2-2-7-Cicatriz 16
2-2-8-Oclusión, obstrucción 16
2-2-9-Mucosa ulcerada 17
2-3-Localización de Las Lesiones: Principios y Decisiones de Consenso 17
2-3-1-Principios generales 17
2-3-2-Decisiones en localizaciones difíciles 17

3-Anatomía Endoscópica Estándar .....

3-1-LOCALIZACIONES ANATÓMICAS ESTÁNDAR 20
3-1-1-Localizaciones del Tracto Gastrointestinal Superior 21
3-1-2-Localizaciones del Tracto Gastrointestinal inferior 21
3-1-3-Localizaciones CPRE (ERCP) 21
3-2-CARACTERÍSTICAS DE LA EXPLORACIÓN 22
3-2-1-Principios y ámbito 22
3-2-2-Lista de términos que describen la extensión de la exploración 23

4-Términos Endoscópicos Estándar 24

4-1-ÁMBITO 24
4-1-1-Consideraciones generales 24

4-1-2-Atributos añadidos y localizaciones.....24
4-2-LISTA DE TÉRMINOS PARA LA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.....24
4-2-1-Lista de términos para el esófago.....24
4-2-2-Lista de términos del estómago.....28
4-2-3-Lista de términos para el duodeno y yeyuno.....31
4-3-LISTA DE TÉRMINOS PARA LA COLONOSCOPIA.....33
4-4-LISTA DE TÉRMINOS PARA LA CPRE (ERCP).....37
4-4-1-Lista de términos para el duodeno.....37
4-4-2-Lista de términos para la papila mayor.....38
4-4-3-Lista de términos para la papila menor.....38
4-4-4-Lista de términos para el páncreas.....39
4-4-5-Lista de términos para la vía biliar 40
4-5-DIAGNÓSTICOS ADICIONALES Y PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS.....41
4-6-COMPLICACIONES.....44

5-Motivos Para La Endoscopia.....**44**

5-1-ÁMBITO.....44
5-2-MOTIVOS PARA LA EXPLORACIÓN.....44

5-2-1-Endoscopia gastrointestinal alta.....45
5-2-2-Endoscopia Gastrointestinal Baja.....45
5-2-3-CPRE (ERCP).....46

6-Diagnóstico.....47

6-1-AMBITO.....47
6-2-LISTA DE DIAGNÓSTICOS PARA EL TRACTO GASTROINTESTINAL ALTO.....47
6-2-1-Esófago.....47
6-2-2-Estómago.....48
6.2.3 Duodeno.....48
6.3 LISTA DE DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL BAJA.....50
6.4 LISTA DE DIAGNÓSTICOS DE CPRE (ERCP).....51
6.4.1 Páncreas.....51
6.4.2 Vía Biliar.....51

7-Bibliografía.....52

8-Historia de las Revisiones.....53

Definiciones.....53

Comité de Terminología Endoscópica Digestiva de A.A.E.D.

Dr. Rubén Eduardo LETTIERI (Coordinador)
Endoscopistas Digestivos de La Pampa

Dr. Héctor Emilio BOLZÁN
Grupo Endoscópico del Centro Bonaerense

Dr. Raúl MATANÓ
Grupo Endoscópico de La Plata

Dra. María de las Mercedes GASTAMINZA
Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires (EnDiBA)

Dr. Juan Pablo ALLONES
Soc. Endoscopía Digestiva de Santiago de Estero

Dr. Ricardo PILEGGI
Grupo Endoscópico Patagónico

Dr. Luis Alberto NARVAEZ
Asociación Sanjuanina de Endoscopía Digestiva

Dr. Bernard Daniel BABOT
Asoc. de Endoscopistas Digestivos de Tucumán

Dr. Francisco LÓPEZ RAFFO
Asociación de Endoscopía Digestiva del Comahue

Dr. Ángel GATTO
Asociación Rosarina de Endoscopía Digestiva

Dr. Mario Pablo ALVARADO
Grupo Endoscópico de Jujuy

Prologo

Terminología Mínima Estándar (MST) en Endoscopia Digestiva

Desde la mítica torre de Babel, el hombre fue condenado a expresarse en distintas lenguas, lo que trató de revertir, infructuosamente, mediante idiomas comunes a todos como el esperanto, que nunca prosperó, y más adelante adoptando el idioma inglés como lengua universal de los negocios. Si bien esto puede ser útil para dicha faz comercial, no lo es para la ciencia. En el particular caso de la medicina, y de nuestra especialidad, la endoscopía digestiva, las diferencias se acentúan, impidiendo el utilizar un idioma común para todos los endoscopistas, y que un informe hecho en cualquier país sea fácilmente traducible al idioma de otro. Merced al visionario trabajo del Prof. Zdenek Maratka, es que la OMED, a través de su comité de MST, cuyo chairman fue el Dr. Michel Delvaux, y que contó con el fantástico apoyo e intenso trabajo del Prof. Massimo Crespi, su mayor impulsor a través de! tiempo, se llegó a la 2° Edición del MST. Tuve el honor de pertenecer a dicho Comité, durante 3 períodos, de 1994-1998; 1998-2002 y 2002-2005, con lo que pude apreciar el intenso trabajo que implica encontrar definiciones claras, entendibles y superponibles a todos los idiomas.

Luego de que el Dr. José Armengol Miró realizara la versión española de dichos términos, con una excelente traducción, el Dr. Rubén Lettieri, oriundo de General Pico, Provincia de La Pampa, con una larga trayectoria en pos de imponer una terminología estándar en endoscopía digestiva, continuó dicha tarea titánica adaptando a su vez el trabajo de Armengol Miró al "idioma" o modismos que utilizamos en Latino América, para hacerlo más accesible a los que la habitamos.

Por lo tanto, como Vicepresidente de OMED e integrante durante tantos años del Comité de MST, me congratulo, y especialmente congratulo al Dr. Lettieri por su inmensa labor, la que sin duda hará más estrechos aún los lazos que guardamos con nuestros hermanos endoscopistas latinoamericanos.

¡Dios salve la Endoscopía!

Prof. Dr. Eduardo G. Segal
Profesor Asociado de Gastroenterología
Vice Presidente de Q.M.E.D.

Prologo

Esta publicación es fruto de la incansable y perseverante tarea del Dr. Rubén Eduardo Lettieri, quien desde hace años recorre el país y Sudamérica predicando sobre la importancia de describir "de la misma manera las mismas cosas", esto tiene enormes beneficios. La falta de una clara comprensión de un informe endoscópico por usar distintas terminologías puede llevar a errores de diagnóstico y tratamiento, además hablar un mismo idioma endoscópico permite realizar trabajos cooperativos con mayor facilidad y contabilidad.

Me alegra mucho la presentación de este libro y no dudo de su utilidad por la claridad de sus conceptos, lo que permitirá que sean llevados a la práctica fácilmente.

Felicito al Dr. Lettieri porque supo a fuerza de capacidad y voluntad interesarnos en el tema y generar el clima propicio para editar esta obra.

Dr. Víctor Hugo Albizzatti
Presidente de la Federación de Asociaciones
Argentinas de Endoscopía Digestiva (AAED)

Prologo y Agradecimientos de esta Edición

Actualmente nadie puede negar la importancia de manejar una terminología estandarizada en endoscopía digestiva, es por eso que desde hace más de quince años me he dedicado al estudio de este tema.

Por esa razón, nuestra propuesta no solamente fue conocer y emplear la terminología, sino difundir, informar, hacer práctico su uso, teniendo como objetivo final que todos los endoscopistas usemos el mismo idioma, en todas las regiones de nuestro país.

Esta publicación de la MST es producto de un esfuerzo permanente y continuo, por lo que me satisface haber logrado concretarlo. Como todo lo mucho o poco que se alcanza en la vida, nada es absoluto y personal. Muchas veces es sólo una gota de agua en el océano. Pero como decía la Madre Teresa de Calcuta, si no hacemos nada "al océano le faltaría una gota". Es por ello que debo agradecer a todos mis colegas endoscopistas digestivos que contribuyeron de una u otra manera a esta realización.

Al editor internacional de la MST Prof. Michel DELVAUX (de Toulouse- Francia) por haberme autorizado a publicarlo. Al Prof. Horacio W. RUBIO quien fue el primero en incentivarme para analizar el tema. Al Profesor Eduardo SEGAL actual vice-presidente de la OMED quien impulsó y autorizó mis inquietudes, aceptando prologar esta publicación. Alos ex-presidentes de AAED: Dres. Ernesto CORIA y Salvador ASCHKENAZY, que apoyaron siempre estas ideas y me dieron el lugar necesario para trabajar. Al presidente actual de la AAED Dr. Víctor Hugo ALBIZZATTI quien concretó mi iniciativa de crear el Comité de Terminología Endoscópica que actualmente coordino, y prologó también esta edición. Al Dr., Héctor BOLZÁN con el que organizamos y realizamos varios Talleres y al Dr. Raúl MATANÓ quien me aportó sugerencias prácticas de actuación.

A los directivos y jefes de Laboratorios ROEMMERS: Sr. Claudio BORSOTTI (Jefe de Línea), Dr. Oscar SECILIO (Jefe Médico de Línea) y Sr. Juan Carlos MARCONETTO (APM) que creyeron en el proyecto y lograron la financiación necesaria para su publicación.

Esta MINIMAL STANDARD TERMINOLOGY IN DIGESTIVE ENDOSCOPY (TERMINOLOGÍA MÍNIMA ESTÁNDAR EN ENDOSCOPÍA DIGESTIVA) en la versión 2.0 y en traducción española (de los Dres. Amergol Miro y Boix Valverde de Barcelona) es lo que les brindamos en esta publicación de distribución gratuita para todos los endoscopistas digestivos, a través de nuestra entidad, la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ARGENTINAS DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA (AAED).

Con esta realización, continuamos dando cumplimiento en forma concreta a los objetivos que nos hemos propuesto en nuestro Comité de Terminología de la AAED, que son estandarizar el uso de una terminología común que permita un informe unificado para nuestra región, que haga simple, accesible y fácilmente entendible nuestro lenguaje endoscópico.

Septiembre de 2005

Dr. Rubén Eduardo Lettieri
Coordinador Comité de Terminología Endoscópica Digestiva de AAED

Presentación

Una terminología simple, precisa, de fácil manejo y conocida por todos, es la herramienta necesaria y fundamental para lograr una correcta descripción de los hallazgos macroscópicos en la práctica de la endoscopía digestiva. Ello amplía y perfecciona nuestros informes al poder diferenciar mejor las observaciones, para lograr un documento mejor valorado y más específico para comunicar su mensaje.

Se trata del idioma común que permitirá entendernos y hacernos entender mejor. Porque el componente escrito del informe que el especialista realiza de su práctica endoscópica, sigue teniendo un valor importante e irremplazable. De esta manera sigue siéndolo en la actualidad, más allá de los progresos de la informática y la incorporación de su uso en los modernos video-endoscopios, que han permitido editar imágenes digitales para ilustrar y ampliar estos informes.

Para estructurar una terminología útil, es necesario recopilar los términos que, por la repetición de su uso en la práctica diaria, consensúan un significado definido, para luego incorporarlos a una base de datos estandarizados y computarizados para su empleo en forma habitual. De esa manera, se evitará definir de varias maneras una misma observación, mejorar su comunicación y darle valor para su uso en estudios nacionales e internacionales multicéntricos.

Pero para que estas nomenclaturas sean realmente útiles, tienen que tener dos condiciones básicas: ser dinámicas, es decir, que se puedan actualizar en forma permanente, y tener el carácter de mínimas, para aceptar agregados que amplíen las descripciones, de acuerdo con los criterios personales o generales de los endoscopistas.

Estos conceptos básicos son los que dieron origen a la Terminología Mínima Estándar (M.S.T.), que motiva esta publicación.

Para los que no hayan tenido contacto previo con el tema, o para aquellos que sólo lo conozcan parcialmente, es necesario exponer algunos antecedentes.

El primer trabajo universalmente conocido en la materia fue el del Profesor Zdenek Maratka de la República Checa: "Terminología, Definiciones y Criterios Diagnósticos en Endoscopía Digestiva", publicado por la Organización Mundial de Endoscopía Digestiva (OMED) en 1984 con una edición española en 1988. Sin embargo, esa terminología no fue muy usada en sistemas informatizados, dado que había términos insuficientemente aclarados y consecuentemente imprecisos; otros equivalentes y algunos con traducciones subjetivas que podían llevar a confusiones.

Debido a ese conocimiento previo de problema, y para tratar de dar una solución, la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal (ESGE) junto con su similar de los EE.UU. (ASGE) y la OMED comenzaron a trabajar en una terminología mínima con la creación del Comité Conjunto de Terminología Mínima Estándar. Al mismo, luego se incorporaron representantes de Japón, el Prof. Maratka, los tres principales fabricantes de endoscopios digestivos (Olympus, Fujinon y Pentax) y la editorial Normed-Verlag.

Fruto de ello fue la publicación de la Minimal Standard Terminology in Digestive Endoscopy (M.S.T.) en 1996 la versión 1.0 y en 1999 la versión 2.0 que es la actual.

El propósito principal del proyecto fue conseguir una lista mínima de términos cuya selección se realizó sobre la base de su empleo en no menos de cien estudios endoscópicos consecutivos, para su uso en sistemas computarizados.

Además de la base de datos, el trabajo detalla las regiones anatómicas, fija pautas para la localización de las lesiones, define términos difíciles o que se presten a discusión, caracteriza la extensión y los límites de la exploración, expone los motivos para realizar una endoscopía digestiva, enumera y estandariza diagnósticos, consigna complicaciones y procedimientos terapéuticos y fundamentalmente realiza una lista de términos por utilizar en cada una de las regiones exploradas, correspondientes a los distintos estudios endoscópicos digestivos (alto, bajo y CPER). Básicamente, en su organización general, se expone en cada órgano:

- la luz (estenosada, deformada).
- el contenido (sangre, moco)

- la mucosa (congestiva, eritematosa)
- lesiones planas (mancha, placa)
- lesiones protruyentes (pápula, pólipo)
- lesiones excavadas (úlcera, erosión)

De esta manera, en el diseño utilizado, se describe el *término* al que se le incluye el *atributo (alteraciones* en la traducción española) que es el conjunto de características o calificativos descriptivos como tamaño, número, extensión, sangrado, etc. al que a su vez se le agregan los *valores del atributo o atributos añadidos* en los que corresponden a cada uno de ellos, como medida en mm, Pediculado, única, múltiple, etc. con lo que se logra una mayor descripción y un mejor ordenamiento de lo observado. Simplificando diremos que se incluye el:

Término	**Atributo** (Alteraciones)	**Valor del Atributo** (Atributos Añadidos)	**Localización**

Por ejemplo: una lesión excavada sería una úlcera. el TÉRMINO es úlcera, el ATRIBUTO o ALTERACIONES son: número, tamaño, profundidad, presencia de sangrado. el VALOR DEL ATRIBUTO o ATRIBUTOS AÑADIDOS son: diámetro en mm, superficial, crateriforme, lineal, tipo de sangrado. y la LOCALIZACIÓN es: en estómago y dentro de él: antro, cuerpo, fundus, curvatura menor o mayor o en duodeno; bulbo, cara anterior, posterior, etc.

Término	**Atributo** (Alteraciones)	**Valor del Atributo** (Atributos Añadidos)	**Localización**
Úlcera	NÚMERO TAMAÑO PROFUNDIDAD PRESENCIA DEL SANGRADO	DIÁMETRO SUPERFICIAL CRATERIFORME LINEAL TIPO DE SANGRADO	ESTÓMAGO (antro, cuerpo, fundus, curvatura menor o mayor) DUODENO (bulbo, cara anterior, posterior, etc.)

Siguiendo este sencillo esquema, se consigue describir los hallazgos con total realidad y fácil traducción. Sólo hay que encuadrar el aspecto y las lesiones vistas en cada órgano con la guía de términos mínimos de la base de datos, sus atributos y valores, a los que se podrán agregar o no, todo lo subjetivo que se desee. El resultado será un informe endoscópico claro, simple y veraz.

Espero que esta publicación de la TERMINOLOGÍA MÍNIMA ESTÁNDAR EN ENDOSCOPÍA DIGESTIVA (MINIMAL STANDAR TERMINOLOGY IN Digestiva ENDOS-COPY) resulte de gran utilidad práctica, contribuya a lograr un mayor conocimiento del tema y sirva, por sobre todo para comenzar a construir *un idioma endoscópico digestivo común* tanto en nuestra región como en el resto del mundo:

Septiembre de 2005.

Dr. Rubén Eduardo Lettieri
Coordinador
Comité de Terminología Endoscópica Digestiva de AAED

Lista de Tablas

Tabla 1. Lugares para la localización de los hallazgos en el tracto gastrointestinal superior.....20

Tabla 2. Lugares para la localización de los hallazgos en el tracto gastrointestinal inferior.....21

Tabla 3. Lugares para la localización de los hallazgos de la CPRE (ERCP.....22

Tabla 4. Términos que describen la extensión y límites de la exploración endoscópica gastrointestinal superior y Colonoscopía.....23

Tabla 5. Términos que describen la extensión y límites de la exploración por CPRE(ERCP)….....23

Tabla 6. Términos para el esófago….....25

Tabla 7. Términos para el estómago.....28

Tabla 8. Términos para el duodeno.....31

Tabla 9. Términos para el colon.....33

Tabla 10. Términos para la papila mayor.....38

Tabla 11. Términos para la papila menor.....38

Tabla 12. Términos para el páncreas.....39

Tabla 13. Términos para la vía biliar 40

Tabla 14. Términos de diagnóstico adicional y procedimientos terapéuticos.....41

Tabla 15. Términos para las complicaciones…….....44

Tabla 16. Motivos para la exploración gastrointestinal alta 45

Tabla 17. Motivos para la realización de una exploración Gastrointestinal baja.....45

Tabla 18. Motivos para realizar una CPRE.....46

Tabla 19. Lista de diagnósticos del esófago.....47

Tabla 20. Lista de diagnósticos del estómago.....48

Tabla 21. Lista de diagnósticos del duodeno.....49

Tabla 22. Lista de diagnósticos del colon.....50

Tabla 23. Lista de diagnósticos del páncreas.....51

Tabla 24. Lista de diagnósticos de la vía biliar….....51

Definiciones, símbolos y abreviaciones

ASGE: Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal

ESGE: Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal

OMED: Organización Mundial de Endoscopia Digestiva

ERCP: Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica(CPRE)

EGD: Esofagogastroduodenoscopia

1-Avance.

La versión 2.0 del MST ha sido preparada por el Comité de Terminología de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE), el Comité de Informática de la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal {ASGE) y el Comité de Terminología y Procesamiento de Datos de la Organización Mundial de Endoscopia Digestiva (OMED). Esta versión 2.0 es el resultado de un estudio multicéntrico extenso en Europa y EEUU, con más de 10.000 procedimientos endoscópicos recogidos prospectivamente. Debido a las diferentes pautas de uso en Estados Unidos de los estándares de indicaciones y diagnóstico, no han sido oficialmente aprobadas por la Junta de Gobierno de la ASGE, aunque se incluyen en la versión 2.0 del MST, mientras que han sido plenamente aceptadas por la ESGE.

El Estándar reemplaza la versión 1.0 del MST y las versiones previas del Datábase de la ASGE. Los cambios en este Estándar modifican significativamente enfoques previos. Estos cambios incluyen;

- Reducción de la lista de términos que se consideran estándar mínimo.
- Eliminación de errores y modificación de denominaciones.
- Inclusión de un listado de títulos que categoriza los términos en grupos más pequeños y lógicos.
- Especificación de los términos que se designan para modificar otros términos.
- Mejora en la descripción de las maniobras endoscópicas realizadas para visualizar las diferentes partes del tracto gastrointestinal.

2-Introducción.

Desde que las computadoras se han hecho más accesibles y económicas, ha aumentado el interés en su uso para almacenar los hallazgos de la endoscopia. Las ventajas son que es posible buscar en cualquier base de datos ya creada, realizar análisis estadístico y evitar la realización de informes escritos a mano o mecanografiados. En todo el mundo se han desarrollado una gran cantidad de sistemas de informes de endoscopia, pero no se ha estandarizado la terminología que se utiliza en ellos. Como resultado de todo esto, se ha perdido una oportunidad de oro para compartir y comparar las bases de datos obtenidas en diferentes centros.

Tras una reunión de "Computadoras en Endoscopia" organizada por el Prof. M. Classen en Munich el año 1991, se hizo aparente que este importante problema necesitaba solucionarse. La Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE)l se decidió a resolver el problema. Se formó un comité bajo la presidencia del Prof. M. Crespi que incluyó un importante número de expertos de Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Italia, España y Reino Unido (1). El Dr. Maratka de la República Checa fue invitado a unirse al Comité dado su trabajo realizado en terminología endoscópica para la Organización Mundial de Endoscopia Digestiva (OMED). En el periodo inicial, se creyó importante que otras zonas del mundo estuvieran representadas, y representantes de EEUU y Japón fueron incorporados al Comité.

Adicionalmente, los tres principales fabricantes de endoscopios {Olympus, Fujinon y Pentax) y la editorial Normed-Verlag fueron invitados a unirse al comité siendo imprescindible que la industria se implicara en este trabajo y desarrollara sus propios sistemas; su compatibilidad entre ellos se consideró vital para compartir datos que debían ser optimizados. También fue importante que estas compañías se involucraran en la discusión de otros aspectos, tales como la captura de imágenes, almacenamiento y transmisión.

Entre 1992 y 1993, se hicieron una serie de reuniones del Comité, que concluyeron con una reunión conjunta de la ESGE y del grupo del Comité de Informática de la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE). En aquel tiempo, se revisó el trabajo realizado, se modificó y el Comité se constituyó en Reunión de Trabajo para realizar un informe para el Congreso Mundial de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva.

El propósito principal del proyecto fue elaborar una lista mínima de términos que pudiera ser incluida en cualquier sistema informático para hacer un informe de los resultados de una exploración endoscópica gastrointestinal. En la fase inicial, se acordó no intentar desarrollar una terminología muy completa para la informatización de los informes endoscópicos, para evitar la experiencia del grupo de la ASGE(2) que resultó un sistema difícil y voluminoso. También se acordó no crear un informe informático para permitir la libre competencia de la industria. Por lo tanto, se intentó que de la Minimal Standard Terminology surgiera una base mínima estándar de términos que deben ser incluidos en cualquier software desarrollado por la industria o por investigadores individuales.

Se decidió que los términos seleccionados deberían tener una amplia aceptación y proporcionar un medio para registrar los hallazgos de la mayoría de exploraciones realizadas. Se debería evitar un excesivo detalle y los hallazgos poco habituales tendrían que estar registrados utilizando campos de "texto libre". Cada término se seleccionó basándose en la expectativa de que pudiera ser utilizado al menos en una de 100 exploraciones consecutivas. Los únicos términos incluidos que no cumplían estos criterios fueron términos descriptivos que se podrían encontrar sólo en algunas zonas del mundo {ej. parásitos), donde podrían ser relativamente frecuentes. Además de la terminología mínima, en el comité se habló de las indicaciones de los procedimientos endoscópicos y del diagnóstico endoscópico. Otros objetivos fueron proveer asistencia en la estandarización del almacenamiento de la imagen endoscópica y la transferencia entre sistemas individuales en la estructura de los informes.

La lista de términos propuestos ha sido ampliamente extraída del trabajo original hecho por el comité de la OMED bajo la presidencia y dirección del Prof. Z. Maratka. Cuando sea publicado por completo, los términos elegidos serán precedidos, cuando sea preciso, por el número de código de la OMED, como ha sido publicado en Terminología, Definiciones y Criterios Diagnósticos en Endoscopia Digestiva, 3° edición. Este proveerá una referencia para los usuarios no familiarizados con las palabras empleadas. Esta referencia ofrece una definición de la terminología junto con sus equivalencias lingüísticas, si el inglés no es la lengua nativa del usuario. Actualmente existen ediciones de este libro en francés, alemán, italiano, español y en otros idiomas.

Para obtener el consenso del Comité, fue necesario incluir unos pocos "términos" que no eran originalmente incluidos en la clasificación de la OMED. Esto fue debido a que estas palabras eran de uso tan frecuente que el comité creyó que tendrían que estar incluidas si la base de datos creada fuera aceptable para ser utilizada por un usuario normal. Similarmente la lista de "atributos" adjuntos a cualquier término para dar más detalle fue restringida a aquéllos que eran empleados con más frecuencia. Como resultado, la cantidad de detalle proporcionado podría ser insuficiente para algunos usuarios de la terminología, en particular los que desean grabar muchos detalles por razones de investigación. Sin embargo, se acordó que cualquier endoscopista que desee grabar detalles extras podría hacerlo, con tal que el sistema computarizado desarrollado contenga la Minimal Terminology. Por esta razón, solamente han sido incluidos los términos usados frecuentemente para describir una lesión. Atributos poco fidedignos como la distancia desde los dientes para una lesión gástrica y desde el margen anal para una lesión del colon situada por encima del recto, no han sido incluidos.

La versión MST 1.0 formaba la base para la comprobación prospectiva de la Terminología en Europa y EEUU. Esta comprobación fue esponsorizada por la Comisión Europea a través del proyecto Gaster y la American Digestive Health Foundation. Los resultados de esta comprobación prospectiva forman la base para las modificaciones hechas a la versión 1.0 que se presentan aquí. Estos cambios han sido revisados y aceptados por los comités de la ESGE y ASGE y constituyen la Minimal Standard Terminology versión 2.0. Ha sido desarrollado un software específico para la comprobación lo cual permitió a los endoscopistas en hospitales universitarios y en la consulta privada, grabar casos endoscópicos utilizando la Minimal Standard Terminology versión 1.0. En Europa el software fue diseñado para proporcionar a los endoscopistas una traducción en los principales idiomas europeos (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Español) y la posibilidad de realizar el análisis final independiente de la lengua original en que los casos habían sido grabados.

(1)Comité de la ESGE para Minimal Standard Terminology: M. Crespi. Roma. Italia (Presidente); L Abbaken, Oslo, Noruega; J.R. Armengol Miró, Barcelona, España; M. Classen, Munich, Alemania; M. Delvaux, Toulouse, Francia; J. Escounrou, Toulouse, Francia; M. Fujino, Yamanashi, Japón; F.

Hagenmüller, Hamburgo, Alemania; W. Heldwein, Munich, Alemania; O. Lemoine, Bruselas, Bélgica; Z. Maratka, Praga, República Checa; T.Rósch, Munich, Alemania; M. Schapiro, Los Angeles, EEUU; L Simón, Szekszard, Hungría; C. Venables, Newcastle, Reino Unido; C. Thaller, Hamburgo, Alemania; F. Zwiebel, Berlín, Alemania y los representantes de Olympus, Fujinon, Pentax y Normed Veríag.

(2)**Ver bibliografía en página 52.**

2-1-Organización General.

Los principios de como se hizo la lista de términos se describen en la página 24. En el mismo párrafo se explica la estructura de los términos, atributos y utilidad de los mismos.

2-2-Decisiones sobre términos difíciles.

El Comité prestó particular atención a los términos que debían incluirse y los que deberían evitarse, para no causar ambigüedad, mal uso o los considerados obsoletos. En la selección de un término, se tuvo en cuenta la necesidad de encontrar una palabra de descripción muy precisa, y la aceptación de estas palabras entre los médicos de diferentes países con diferentes lenguas. También hubo el problema de palabras diferentes pero estrechamente relacionadas, palabras utilizadas más frecuentemente en una lengua que en otra. Esto condujo a la selección de términos basados en el inglés con unas pequeñas diferencias entre Europa y Estados Unidos. Las traducciones de estos términos a otras lenguas debería basarse en las traducciones oficiales encontradas en la terminología de la OMED.

2-2-1-Estenosis.

Una estrechez en un segmento del intestino puede ser descrita de varias formas: "estrechez", "estrechamiento", "estenosado", "compresión". Todos estos términos han sido agrupados en la terminología bajo el término genérico "estenosis". El mismo término ha sido utilizado para describir la estrechez de un esfínter que impide el paso del endoscopio o requiere forzar para sobrepasarlo. El término funcional "espasmo" ha sido evitado por su naturaleza subjetiva. Una vez que ha sido descrita una estenosis se la califica mediante unos atributos de utilidad: "extrínseca", "benigna intrínseca" o "maligna intrínseca", basados en la causa más probable. En los casos de compresión extrínseca, donde no se aprecia una verdadera estenosis de la luz, ej. prominencia de la aorta, el término "estenosis" no debería usarse.

2-2-2-Mucosa roja, eritema, mucosa congestiva, hiperemia.

Durante prolongadas discusiones sobre qué términos debían ser incluidos en la Minimal Standard Terminology, se puso de manifiesto que todos los términos anteriormente mencionados se usaron para definir aproximadamente lesiones similares o para patrones de la mucosa. Finalmente se llegó al acuerdo de que sólo era necesario distinguir entre una mucosa de aspecto eritematoso o congestivo. La mucosa eritematosa se define como una mucosa con enrojecimiento focal o difuso sin ninguna otra modificación; la mucosa congestiva, por otra parte , se define como la combinación de eritema con una mucosa edematosa, hinchada o friable. Debido a la gran sobreposición de estos términos, se acordó que hiperemia fuera equivalente a eritema y edematoso equivalente a mucosa congestiva. Por ello estas palabras podrían ser usadas como una alternativa pero no añadidas simultáneamente al número de términos utilizados.

2.2.3 Mucosa esclerosada.

Este término se utiliza para describir los cambios mucosos y submucosos post-escleroterapia que pueden aparecer en el esófago tras escleroterapia endoscópica de varices esofágicas. Aunque el término "fibrosis" describe primariamente cambios histológicos, se utiliza también frecuentemente y se acepta como equivalente a esclerosis. Exigentes estudios muestran que el término mucosa esclerosada también

fue utilizado para describir el aspecto del tercio inferior del esófago esclerótico en ausencia de antecedentes de tratamiento de varices. Para superar este doble significado del término, ha sido añadido un atributo para especificar si es espontáneo o post-terapéutico.

2-2-4-Erosión, afta.

En la terminología original de la OMED, el término "erosión" ha sido evitado porque se consideró impreciso y requería confirmación histológica; "afta" es por lo tanto el término preferido. Durante extensas discusiones, el Comité ha llegado a la conclusión que el término "erosión" es el más utilizado en la mayoría de lenguas que se incluyen en la Minimal Standard Terminology.

No obstante es necesaria una estricta definición de este término. "Erosión" se define como un pequeño defecto superficial de la mucosa, de color blanco o amarillo, con un borde plano. Puede sangrar, pero el término sólo puede ser utilizado cuando la mucosa se puede ver bien y no está cubierta de coágulos hemáticos.

En el colon, se decidió conservar el término "afta", y se acordó que las aftas se encuentran más frecuentemente en esta zona y son un hallazgo diagnóstico de la "enfermedad de Crohn". En este contexto, se definen las aftas como manchas blancas o amarillas rodeadas de un halo rojo frecuentemente con una mancha en el centro. Las aftas se ven habitualmente dentro de una mucosa congestiva o eritematosa y son habitualmente múltiples.

2-2-5-Tumor, masa.

En las recomendaciones originales del Comité, la palabra "tumor" se usó para describir cualquier lesión que parece de naturaleza neoplásica, pero sin ningún intento de decir si es benigna o maligna. No se utiliza para las lesiones pequeñas tales como gránulos, pápulas, etc., . tampoco para otras lesiones protruyentes como pólipos, varices o pliegues gigantes. La revisión conjunta con la ASGE reveló dificultades con este término dado que en los EEUU, los pacientes asumen que el tumor es una lesión maligna. Por esta razón, se acordó que el término "masa" podría ser utilizado como un término equivalente cuando sea necesario.

2-2-6-Angiectasia.

.

Bajo este término genérico se agrupan las telangiectasias y las angiodisplasias. Esto es debido a que no hay criterios diagnósticos visuales precisos que permitan distinguir entre estas dos lesiones. Este término se aplica a las malformaciones vasculares congénitas o adquiridas de la mucosa del tracto gastrointestinal.

2-2-7-Cicatriz.

El término "cicatriz" es preferible al término "fibrosis" dado que este último implica una confirmación histológica del proceso. El aspecto cicatricial de la mucosa tras la curación de una úlcera o después de un procedimiento terapéutico (ej. escleroterapia, fotocoagulación con láser), parece más adecuado para esta palabra.

2-2-8-Oclusión, obstrucción.

Según la definición contenida en la terminología de la OMED, "obstrucción" significa el bloqueo de una estructura tubular por un obstáculo intraluminal {ej. cuerpo extraño), mientras que "oclusión" implica un cierre completo de la luz por una lesión intrínseca de la pared (ej. fibrosis de una úlcera duodenal curada que causa una estenosis pilórica). Aunque las obstrucciones y oclusiones pueden ser cualquiera de las dos parciales o completas, el uso de estos dos términos puede dar sensación de confusión y crear dificultades cuando se traduce a otros idiomas. Por todo ello, hemos decidido restringir el uso del término "obstrucción" a dos situaciones: (I) la presencia de un tumor exofítico en un órgano tubular; (II) los hallazgos en la vía biliar o conducto pancreático en las radiografías obtenidas mediante una CPRE (ERCP). Este término cubre parcial o por completo la interrupción del paso del contraste por el conducto, cualquiera que sea la causa de la

obstrucción (ej. cálculo, tumor, cuerpo extraño). En el caso de una obstrucción en un órgano tubular, esta obstrucción se debe describir como parcial o completa, dependiendo si existe o no luz.

2-2-9-Mucosa ulcerada.

Los endoscopistas creyeron que debería haber una diferencia conceptual entre las úlceras que son múltiples y la mucosa ulcerada. Está probado que este término describe a la mucosa ulcerada difusamente y que este concepto se utiliza frecuentemente en EEUU y en Europa y que cuando se usa por los endoscopistas, es para hacer referencia a un aspecto global de la mucosa típico de la colitis ulcerosa.

Por tanto, " mucosa ulcerada" ha sido introducida en la versión 2.0. Debemos enfatizar que este término debe ser usado sólo en caso de una mucosa difusamente ulcerada cuando el endoscopista distingue este concepto del de "úlceras" que son múltiples. No obstante, se reconoce que el uso de este término necesita ser evaluado en estudios prospectivos, para definir mejor su significado y si este concepto es distinto del término "úlcera".

2-3-Localización de las lesiones: Principios y Decisiones de Consenso.

2-3-1-Principios generales.

Aunque la localización de las lesiones es un punto clave en cualquier descripción de un término, las especificaciones tales como la distancia desde los dientes o del margen anal podrían ser imprecisas en algunos órganos o sitios. Se decidió, por tanto, que estas "especificaciones de distancia" deberían emplearse sólo cuando el órgano examinado permita que sean relevantes {ej. esófago en la endoscopia alta y recto en la colonoscopía).

En algunos casos, deben realizarse múltiples registros de sitios, como ante algunas lesiones múltiples que necesitan especificar el lugar de cada una de ellas, o cuando la precisa localización de la lesión necesita el uso de dos términos (ej. en el estómago, un tumor de crecimiento en la "pequeña curvatura" y en el "antro").

2-3-2-Decisiones en localizaciones difíciles

Entre las muchas localizaciones definidas en la terminología, hay algunas en que sólo se ha llegado a acuerdo tras una discusión prolongada. Los argumentos para estas decisiones son los siguientes:

2-3-2-1-Cardias, Hiato, Esfínter Esofágico Inferior.

Hay muchos términos que han sido utilizados para describir la zona de la unión esófago-gástrica (Figura 1A). Si bien estos pueden ser definidos cuidadosamente , se ha asumido a menudo que son sinónimos y como resultado, se usan incorrectamente. Para clarificar esta situación, se ha decidido omitir el término "esfínter esofágico inferior" de la lista de localizaciones de la sección del esófago, dada su dificultad en identificarlo, al ser una entidad funcional y no debe ser utilizada como un punto fijo para localizar una lesión propia. No obstante, este término debe incluirse como un término específico dentro de la categoría "Luz", que permita al usuario del sistema reportar su aspecto (ej. muy abierto o hipertónico). La "unión esófago-gástrica" implica una transición desde el esófago al estómago pero es habitualmente utilizado para la unión mucosa {línea Z). Debe evitarse, por tanto como una localización, porque puede ser localizado aparte de la unión exacta entre el esófago y el estómago.

"Hiato" describe el orificio en el diafragma que puede ser difícil de identificar y tiende a causar dificultades cuando definimos una hernia de hiato. Por estas razones, el término "cardias" se escogió para describir la totalidad de esta zona. Tras las pruebas iniciales de la terminología, se convino que esto causaría problemas cuando se describe una hernia de hiato. Inicialmente, se acordó que el tamaño de las hernias deberían simplemente reportarse como "pequeña" o "grande". No obstante, algunos usuarios buscan describir el tamaño de la hernia como la distancia entre la línea Z y la referencia anatómica definida por el paso del diafragma. Igualmente, la longitud del esófago de Barrett se define como la distancia entre

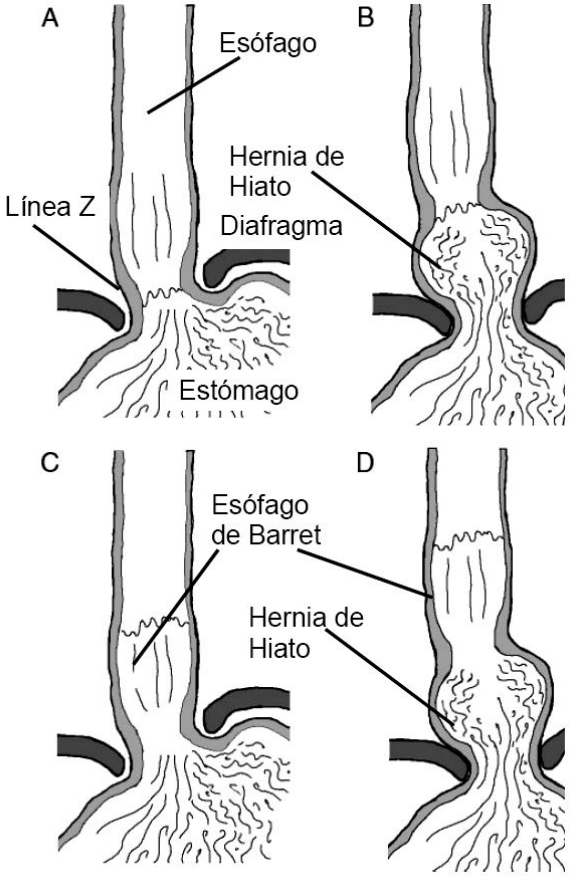
la transición de la mucosa esofágica a la mucosa gástrica (línea Z) y la referencia anatómica del final del aspecto de tubería lisa del esófago. Por esta razón, el término "estrechez hiatal" se incluye en la versión 1.0 de la terminología. Ello debería permitir una mejor especificación de la longitud de un esófago de Barrett y posiblemente de una hernia de hiato. No obstante, las pruebas de la versión 1.0 del MST indican que la localización del cardias y los términos línea Z y estrechez Hiatal son poco comprendidos por los usuarios. Para clarificar la descripción se han hecho las siguientes modificaciones:

- La posición de la línea Z (dada en cm. desde los incisivos) podría ser especificada como un atributo normal de la Hernia de Hiato y del Esófago de Barrett.

- La estrechez del hiato se utiliza como una medida de distancia de la Hernia de Hiato. Esta referencia anatómica, cuando se combina con la medida de distancia de la línea Z, debería definir con más precisión la longitud de una Hernia de Hiato.

- La parte superior de los pliegues gástricos se utiliza como la medida de distancia en el Esófago de Barrett. Este cambio, cuando se combina con la medida de distancia de la línea Z debería definir con más precisión la longitud de un Esófago de Barrett.

Figura 1.



2-3-2-2-Fundus gástrico, Cuerpo gástrico y Antro.

Se utiliza Fundus para describir la zona anatómica del estómago que se extiende por debajo del diafragma en el examen baritado. En la terminología de la OMED el término "fundus" se contempla como confuso y se prefiere el término "fornix" para describir la zona superior del estómago durante la maniobra de retrovisión. En la terminología mínima estándar recomendada, el término "fundus" ha sido utilizado y es, comúnmente empleado, por lo que se creyó que no era aconsejable retirarlo.

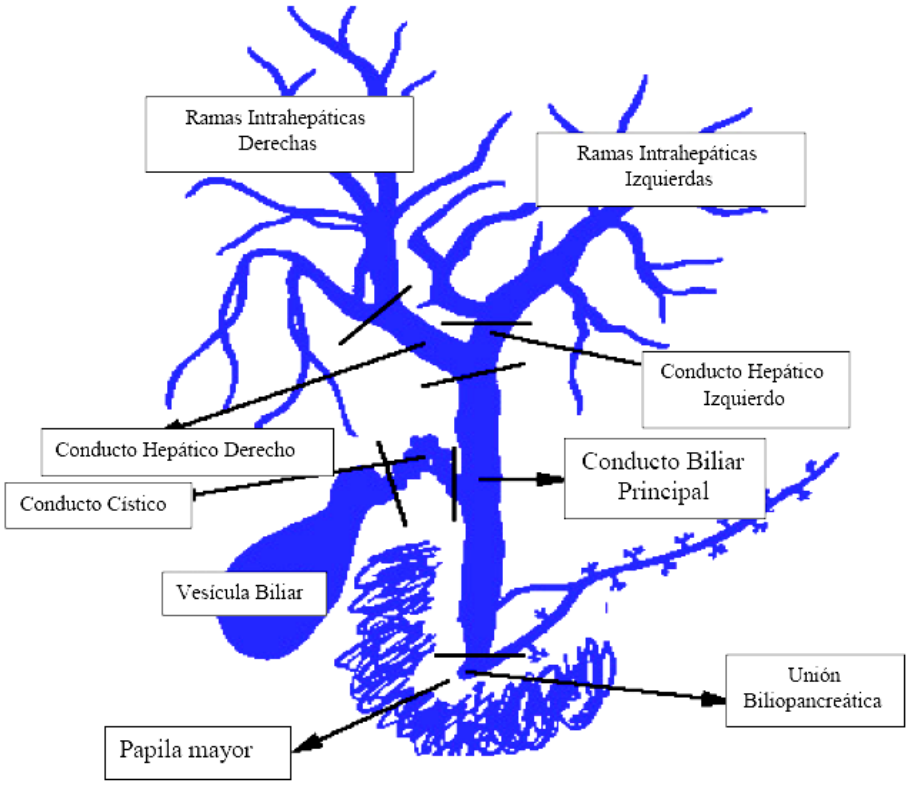
El cuerpo gástrico se define como el área del estómago por encima de la incisura angularis que se encuentra habitualmente revestido por pliegues de mucosa gástrica. El antro se define como la parte distal del estómago revestida habitualmente por una mucosa plana.

2-3-2-3-Árbol Biliar.

Existe un problema en la descripción del árbol biliar La división anatómica en "conducto hepático común" y "colédoco" dentro de los conductos extrahepáticos se define por la zona de implantación del conducto cístico. Esta división no deja margen para la variabilidad de esta unión y crea una considerable confusión cuando se intenta identificar el lugar de una lesión dentro de los conductos extrahepáticos. Por este motivo se decidió identificar el lugar llamado "conducto biliar principal", que abarca a ambos, al conducto hepático común y al colédoco, localizando cualquier lesión, situada en el tercio superior, medio o inferior de este conducto (Figura 2).

Los conductos intrahepáticos principales fueron identificados como conductos hepáticos derechos e izquierdos desde la unión de la porta hepatis y su primera subdivisión. Todos los otros conductos dentro del hígado se llaman conductos intrahepáticos.

Figura 2.



Endoscopia Digestiva Terminología Mínima Estándar

El propósito principal de este proyecto fue elaborar una lista mínima de términos que pudiera ser incluida en cualquier sistema informático para documentar los resultados de una exploración endoscópica. En una fase inicial, se acordó no intentar desarrollar una terminología muy completa para informatización de los informes endoscópicos, para evitar la experiencia del grupo de la ASGE{1) que resultó un sistema difícil y engorroso.. Se decidió que los términos seleccionados deberían tener una amplia aceptación y proporcionar un medio para registrar los hallazgos de la mayoría de exploraciones realizadas. Se evitó un excesivo detalle y los hallazgos raros se registraron utilizando campos de texto libre. Cada término se seleccionó basándose en la expectativa de que pudiera ser utilizado al menos en 1 de 100 exploraciones consecutivas. Los únicos términos incluidos que no cumplían estos criterios fueron términos descriptivos que se podrían encontrar sólo en algunas zonas del mundo (ej. parásitos), donde podrían ser relativamente frecuentes.

Además de la terminología mínima, en el comité se habló de las indicaciones de los procedimientos endoscópicos y del diagnóstico endoscópico. Otros objetivos fueron proveer asistencia en la estandarización del almacenamiento de la imagen endoscópica y la transferencia entre sistemas individuales en la estructura de los informes. En la sección siguiente se presentan los términos específicos utilizados para describir la localización de los hallazgos.

3-Anatomía Endoscópica Estándar.

Las zonas anatómicas se dividen en secciones separadas dependiendo de la exploración endoscópica a realizar. Forman un grupo arbitrario que se designa para facilitar su revisión. Cuando sea necesario, se incluirán figuras para definir más precisamente la localización.

3-1-Localizaciones Anatómicas Estándar

3-1-1-Localizaciones del Tracto Gastrointestinal Superior.

La siguiente tabla se utiliza para determinar las localizaciones de los hallazgos del tracto gastrointestinal superior.

Tabla 1: Lugares para la localización de los hallazgos en el tracto gastrointestinal superior

Órgano	Lugar	Alteraciones
Esófago	Crico-faringe	
	Tercio superior	
	Tercio medio	
	Tercio inferior	
	Cardias	
	Totalidad del esófago	
	Anastomosis	
Estómago	Cardias	
	Fundus	Gran curvatura
		Pequeña curvatura
		Pared anterior
		Pared posterior
	Cuerpo	Gran curvatura
		Pequeña curvatura
		Pared anterior
		Pared posterior

	Incisura angularis	
	Antro	Gran curvatura
		Pequeña curvatura
		Pared anterior
		Pared posterior
	Pre-pilórica	
	Píloro	
	Totalidad del estómago	
	Anastomosis	
	Piloroplastia	
Duodeno	Bulbo	Anterior
		Posterior
		Proximal
		Distal
	2° porción del duodeno	
	Área papilar	
	Anastomosis	
	Totalidad del duodeno examinado	
Yeyuno	Asa aferente yeyunal	
	Asa eferente yeyunal	
	Carina yeyunal	

3-1-2-Localizaciones del tracto gastrointestinal inferior.

La siguiente tabla se utiliza para determinar las localizaciones de los hallazgos en el tracto gastrointestinal inferior.

Tabla 2. Lugares para la localización de los hallazgos en el tracto gastrointestinal inferior.

Órgano	**Lugar**
Colon	Ano
	Recto
	Sigma
	Descendente
	Esplénico
	Transverso
	Hepático
	Ascendente
	Ciego
	Válvula ileocecal
	Estoma
	Totalidad del colon
	Anastomosis
	Bolsa rectal
Ileon	

3-1-3-Localizaciones CPRE (ERCP.

La siguiente tabla se utiliza para determinar las Realizaciones de los hallazgos de la CPRE (ERCP).

Tabla 3. Lugares para la Realización de los hallazgos de la CPRE (ERCP).

Órgano	Lugar	Alteraciones
Páncreas	La totalidad	
	Cabeza	
	Cuerpo	
	Cola	
	Conducto principal	
	Conducto accesorio	
	Ramas	
Vía Biliar	Papila	
	Unión Biliopancreática	
	Conducto biliar principal	La totalidad
		Tercio inferior
		Tercio medio
		Tercio superior
	Conducto cístico	
	Bifurcación	
	Conductos hepáticos	Conducto hepático derecho
		Conducto hepático izquierdo
		Ramas intrahepáticas izquierdas
		Ramas intrahepáticas derechas
		Todas las ramas intrahepáticas
Vesícula Biliar		

3-2-Características de la exploración.

3-2-1-Principios y ámbito.

Las características de la exploración se refieren a la extensión y límites de la exploración. La extensión de la exploración se define como la extensión anatómica de la exploración. Los límites de la exploración se definen como cualquier limitación que impida la adecuada ejecución del procedimiento. Es sabido que existe una sobreposición entre los conceptos extensión y límite. En esta sección se intenta transmitir de forma explícita aquellas características de la exploración que afectan la integridad de la misma, cualquier limitación que impida una exploración completa y las maniobras necesarias para ejecutarla.

La extensión de la exploración se especifica en los lugares anatómicos más lejanos alcanzados o una lista de localizaciones anatómicas visualizadas. En la colonoscopía, si se alcanza el ciego, entonces la localización anatómica "ciego" especifica la extensión de la exploración. En la CPRE (ERCP), si sólo se visualizan las vías biliares, es necesario especificar que la extensión de la exploración ha sido la vía biliar.

El límite de la exploración se especifica por algunas restricciones de la exploración, ya sean resultado de una preparación inadecuada o de anomalías anatómicas o barreras. En la colonoscopía la calidad de la limpieza intestinal es un factor principal para la calidad del procedimiento, especialmente cuando se buscan lesiones pequeñas o planas. La mala preparación se considera una limitación para la exploración. Una estenosis en un segmento del tracto gastrointestinal que requiera una intervención para poder completar la exploración, se considera también una limitación para la exploración. Por ejemplo, una estenosis imposibilita el paso del endoscopio pero su dilatación permite el avance del instrumento. Esto también ocurre en la CPRE(ERCP) donde parte del informe endoscópico describe las diversas maniobras que se realizan para conseguir la canulación y/o opacificación de los conductos.

3-2-2-Lista de términos que describen la extensión de la exploración

Las siguientes tablas se utilizan para definir la extensión y límites de la exploración.

Tabla 4. Términos que describen la extensión y límites de la exploración endoscópica gastrointestinal superior y colonoscopía.

Termino	Alteraciones	Atributos Añadidos	Localización
Preparación	Método	Especificar	
	Cualidad	Excelente	Lugar(es)
		Adecuada	
		Inadecuada:	
		Exploración Completa	
		Imposibilita una exploración completa	
Extensión de la exploración	Situación		Lugar(es)
Limitación	Motivo	Adherencias	Lugar(es)
		Bucle colónico	
		Estenosis	
		Mala preparación	
		Problemas técnicos	
		Especificar	

Tabla 5. Términos que describen la extensión y límites de la exploración por CPRE (ERCP)

Termino	Alteraciones	Atributos Añadidos	Localización
Acceso a la papila	Motivo	Acceso	Inalcanzable
		No encontrada	
		Inaccesible	
		Especificar	
Canulación	Conducto	Pancreático	
		Biliar	
	Resultado	Éxito: Profundidad	
		Éxito: Superficial	
		Fallido	
		No intentada	
		Inyección submucosa	
	Método	Canulación libre	
		Sobre guía	
		Tras precorte	
	Instrumento	Cánula	
		Cánula de punta metálica	
		Esfinterotomo	
		Catéter de balón	
		Catéter de manometría	
Opacificación	Conducto	Biliar	
		Pancreático	
	Resultado	Exitoso: Completo	
		Exitoso: Parcial	
		Fallido	

		No intentada	
		Reflujo de medio de contraste	
		Extravasación	

Requisitos para la Base de Datos:

4.0 Términos Endoscópicos Estándares

4.1 Ambito

4-1-1-Consideraciones generales.

Los términos han sido organizados por tipo de exploración (Endoscopia Gastrointestinal superior, Colonoscopía y CPRE), con una lista complementaria adicional de Procedimientos Terapéuticos que pueden ser realizados. Dentro de cada tipo de exploración, los términos han sido agrupados bajo varios títulos utilizados en la terminología de la OMED para cada órgano explorado. Hay alguna excepción para los términos incluidos bajo estos títulos. El más notable es la inclusión de los hallazgos posquirúrgicos bajo el título "Luz". Mientras que esto no es una "lesión", es obvio que los cambios manifiestos tras una operación quirúrgica se verán mientras se explora la luz de un órgano determinado (ej. una anastomosis ileocólica mientras se explora un colon o una anastomosis de un Billroth II cuando exploramos un estómago) y debe ser reportado en este momento,.

La lista de términos presentados para cada localización varía con el órgano que se explora- Por ejemplo, el término "esofagitis" sólo aparece en la sección esofágica, mientras que I término "mancha" está presente en estómago y colon, pero no en esófago. Por ello, la de términos varía donde un término particular se hace inapropiado para una localización precisa.

Los términos utilizados para describir los cambios funcionales tales como la contractibilidad y elasticidad de la pared, aumento o descenso del peristaltismo, estrechez funcional o deformidad extrínseca han sido excluidos de la terminología mínima, al haberlos considerado demasiado subjetivos e imprecisos para ayudar a hacer un diagnóstico. Además, estos términos eran demasiado susceptibles a ser mal interpretados para ser usados en estudios multicéntricos.

4-1-2-Atributos añadidos y localizaciones.

Cuando conviene, cada término se une a atributos calificativos que le proporcionan un detalle adicional. Los atributos son una lista de términos descriptivos tales como tamaño, número, extensión, etc..para los cuales hay una serie de valores apropiados a cada término. Por ejemplo, los atributos de una úlcera duodenal incluyen: tamaño(en milímetros); forma (superficial, crateriforme o lineal);: sangrado (sí o no "estigmas de hemorragia reciente", definidos en la clasificación de Forrest). Cada lesión descrita se coloca en su localización utilizando la lista de localizaciones relevantes del órgano examinado.

4-2-Lista de términos para la esofagogastroduodenoscopia.

Los siguientes términos deben ser utilizados para describir las observaciones hechas durante las exploraciones del tracto gastrointestinal superior.

4.2.1 Lista de términos para el esófago.

Los siguientes términos deben ser utilizados para describir las observaciones hechas durante las exploraciones del esófago.

Tabla 6. Términos para el esófago.
17

Títulos	Termino	Alteraciones	Atributos Añadidos	Localización
Normal	Normal			Lugar(es)
Luz	Dilatada			Lugar(es)
	Estenosis	Aspecto	Extrínseca	Lugar(es)
			Benigna intrínseca	desde los incisivos
			Maligna intrínseca	
		Longitud(cm.)		
		Sobrepable	Si	
			Tras dilatación	
			No	
	Compresión Extrínseca *(Este término debería aplicarse sólo en ausencia de estenosis de la luz)*	Tamaño	Pequeña*	Lugar(es)
			Grande*	
	Membrana			Lugar(es)
	Anillo (incluye de Schatzki)		Lugar(es)	
	Hernia de Hiato	Tamaño / Volumen	Pequeña *	Lugar(es)
			Mediana*	
			Grande*	
		Lugar de la línea Z cm.	desde los incisivos	
		Lugar de la estrechez hiatal	desde los incisivos	
	Esfínter esofágico Inferior *(Cardias" podría ser utilizado en lugar de "esfínter esofágico inferior)*	Tono	Abierto Hipertónico	
	Evidencia de cirugía previa	Anastomosis	Esófagoyeyunal	Cm desde los incisivos
			Esofagogástrica	
			Esofagocolónica	
		Material de sutura visible	Si	Lugar(es)
			No	Lugar(es)
Contenido	Cuerpo extraño	Tipo	Especificar	Lugar(es)
	Sangre	Aspecto de sangre	Roja	Lugar(es)
			Coágulo	
			Hematina(sangre alterada)	
	Alimento			Lugar(es)
	Bilis			Lugar(es)
	Prótesis	Tipo	Especificar	Lugar(es)
	Banda	Numero		Lugar(es)
		Posición	Libre	

			Adherido	
Mucosa	Eritematosa (Hiperémica)	Extensión	Parcheada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
	Esofagitis	Grado *(Los grados se definen de acuerdo con la clasificación de Savary-Miller (Scand. J. Gastroenterol- 1984:19:26-44)*	Grado 1 [4]	Borde superior (cm. desde los incisivos)
			Grado II	
			Grado III	
			Grado IV	
		Sangrado	Si	
			No	
	Esófago de Barrett	Distancia	Línea Z	cm. desde los incisivos
		Distancia	Extremo superior de pliegues gástricos	Cm desde los incisivos
	Candidiasis	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
	Mucosa esclerosada *(También se podría usar "fibrosis")*	Tipo	Espontánea *	Lugar(es)
			Post-trata miento	
		Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada	
			Difusa*	
Lesiones Planas	Mucosa gástrica ectópica	Número	Unica*	Lugar(es)
			Múltiples*	
	Placa	Número	Única*	Lugar(es)
			Múltiples*	
Lesiones protruyentes	Nódulo	Número	Única*	Lugar(es)
			Pocas*	
			Muchas	
		Extensión	Localizada*	
			Parcheada*	
			Difusa*	
	Tumor/Masa *(Masa se* utiliza en lugar de tumor en EEUU)	Tamaño	Pequeña*	Lugar(es)
			Mediano*	

			Grande*	
		Tipo	Submucoso	
			Vegetante	
			Ulcerado	
		Circunferencial	Si	
			No	
		Obstructivo	Parcial	
			Completa	
		Sangrante	Si	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Varices	Grado (*Los grados se definen conforme a la clasificación mayormente utilizada en la literatura .Ej. Gastroenteroiogy 1967: 52: 810-818: Gastroenterology 1990:98 156-162)*	Grado I	Lugar(es)
			Grado II	
			Grado III	
		Tamaño	Anchura estimada en mm	
		Límite superior		Cm desde los incisivos
		Sangrado "	Si: a chorro	
			Si: rezumado	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
		Signos rojos	Si	
			No	
Lesiones excavadas	Sindr. Mallory Weiss	Sangrado	Si: a chorro	Lugar(es}
			Si: rezumado	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Erosión	Número	Única*	Lugar(es)
			Pocos*	
			Muchos*	
	Ulcera	Número		Lugar(es)
		Tamaño (mm)		cm. desde los incisivos
		Sangrado	Si: a chorro	
			Si: rezumado	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	

	Cicatriz			Lugar(es)
	Divertículo			Lugar(es)
	Fístula			Lugar(es)

*Ver en página 53 Definiciones.

4-2-2-Lista de términos del estómago

Los siguientes términos deben ser utilizados para describir las observaciones realizadas c-rante la exploración del estómago.

Tabla 7:Términos para el estómago

Títulos	Termino	Alteraciones	Atributos Añadidos	Localización
Normal	Normal			Lugar(es)
Luz	Estenosis	Aspecto	Extrínseca	Lugar(es)
			Benigna intrínseca	
			Maligna intrínseca	
		Estenosis	Si	
			No	
	Deformación			Lugar(es)
	Compresión Extrínseca			Lugar(es)
	Evidencia de cirugía previa	Anastomosis	Billroth I	
			Billroth II	
			Gastroenteroanastomosis	
			Piloroplastia	
			Cirugía antirreflujo	
			Gastroplastia anillada	
		Material de sutura visible	Si	Lugar(es)
			No	
	Gastrostomia	Tipo	Quirúrgica	Lugar(es)
			Endoscópica (GEP)	
Contenido	Sangre	Aspecto de sangre	Roja	Lugar(es)
			Coágulo	
			Hematina(sangre alterada)	
	Restos alimentarios	Tipo	Especificar si forman bezoar	Lugar(es)
	Fluidos	Aspecto	Claro	Lugar(es)
			Excesivo	
			Bilioso	
	Cuerpo Extraño	Tipo	Especificar	Lugar(es)
	Prótesis	Tipo	Especificar	Lugar(es)
Mucosa	Eritematosa (Hiperémica)	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			A tiras*	
			Difusa*	
	Congestiva (Edematosa)	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	

		Sangrado	Si	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Granular	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
	Friable	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si: espontáneo	
			Si: al contacto	
			No	
	Nodular	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
	Atrófica	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
	Hemorrágica	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
	Petequias	Número	Única*	Lugar(es)
			Pocas*	
			Múltiples*	
		Extensión	Localizada*	Lugar(es)
Lesiones Planas	Mancha (área)	Número	Única*	Lugar(es)
			Pocos*	
			Múltiples*	
		Extensión	Localizada*	
			Parcheada*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si	
			Subepitelial	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Lesion de Dieulafoy	Sangrado	Si: a chorro	Lugar(es)
			Si: rezumado	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Angioectasia	Número	Única*	Lugar(es)
			Pocas*	
			Múltiples*	
		Extensión	Localizada*	
			Parcheada*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si	
			No	

		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
Lesiones protruyentes	Pliegues engrosados	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Difusa*	
		Tipo *(La diferencia entre pliegue grueso y gigante se debe basar en la desaparición de los pliegues con la insuflación del estómago)*	Grueso	Lugar(es)
	Pápula (Nódulo)	Número	Única*	Lugar(es)
			Pocos*	
			Múltiples*	
		Sangrado	Si	
			No	
	Pólipo	Número	Única*	Lugar(es)
			Pocas*	
			Múltiples*	
		Pedículo	Sésil	
			Pediculado	
		Tamaño	Pequeño* (< 5 mm)	
			Mediano* (5-20 mm)	
			Grande* (> 20 mm)	
		Sangrado	Si	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Tumor/Masa	Tamaño	Pequeña*	Lugar(es)
			Mediano*	
			Grande*	
			diámetro en mm	
		Tipo	Submucoso	
			Vegetante	
			Ulcerado	
			Infiltrante	
		Circunferencial	Si	
			No	
		Sangrado	Si: a chorro	
			Si: rezumado	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Varices	Sangrado	Si: a chorro	Lugar(es)
			Si: rezumado	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Granuloma por sutura			Lugar(es)

*Ver en página 53 Definiciones.

4-2-3-Lista de términos para el duodeno y yeyuno

Los siguientes términos deben usarse para describir las observaciones hechas durante la exploración del duodeno.

Tabla 8. Términos para el duodeno

Títulos	Termino	Alteraciones	Atributos Añadidos	Localización
Normal	Normal			Lugar(es)
Luz	Estenosis	Aspecto	Extrínseca	Lugar(es)
			Benigna intrínseca	
			Maligna intrínseca	
		Sobrepasable	Si	
			No	
	Deformidad	Aspecto	Extrínseco	Lugar(es)
			Post-Ulcerosa	
	Evidencia de cirugía previa	Especificar		Lugar(es)
		Material de sutura visible	Si	Lugar(es)
			No	
Contenido	Sangre	Aspecto de sangre	Roja	Lugar(es)
			Coágulo	
			Hematina(sangre alterada)	
	Parásitos			Lugar(es)
	Cuerpo Extraño			Lugar(es)
	Prótesis	Tipo	Especificar	Lugar(es)
Mucosa	Eritematosa (Hiperémica)	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	-
			No	
	Congestiva (Edematosa)	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	•
			No	
	Granular	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
	Friable	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si: Espontáneo	
			Si: Sangrado al contacto	
			No	

	Nodular	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Difusa*	
	Atrófica	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
	Hemorrágica	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Parcheada*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
Lesiones planas	Mancha (área)	Número	Única*	Lugar(es)
			Pocas*	
			Múltiples*	
		Extensión	Localizada*	
			Parcheada*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si	
			No	
			Subepitelial	
			Tenido de Hematina (Sangre alterada)	
	Angioectasia	Número	Única*	Lugar(es)
			Pocas*	
			Múltiples*	
		Extensión	Localizada*	
			Parcheada*	
			Difusas*	
		Sangrado	Si	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
Lesiones protruyentes	Pólipo(s)	Número	Único	Lugar(es)
			Pocos*	
			Múltiples*	
		Tamaño	Pequeño* (< 5 mm)	
			Mediano* (5-20 mm)	
			Grande* (> 20 mm)	
		Pedículo	Sésil	
			Pediculado	
		Sangrado	Si	
			No	
	Tumor/Masa	Tamaño	Pequeño*	Lugar(es)
			Mediano*	
			Grande*	
			Diámetro mayor en mm	
		Tipo	Submucoso	Tipo
			Vegetante	

			Ulcerado	
			Infiltrante	
			Velloso	
		Sangrado	Si: a chorro	Sangrado
			Si: rezumado	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	Estigmas de sangrado
			No	
Lesiones excavadas	Erosión	Número	Única*	Lugar(es)
			Pocos*	
			Múltiples*	
		Extensión	Localizada*	
			Segmentarías*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Ulcera	Número		Lugar(es)
		Tamaño	Diámetro mayor en mm	
		Forma	Superficial	
			Crateriforme	
			Lineal	
		Sangrado	Si: a chorro	
			Si: rezumado	
			No	
		Estigmas de		
		sangrado	Vaso visible	
			Coágulo	
		Material pigmentado	No estigmas	
	Cicatriz	Número	Única*	Lugar(es)
			Múltiples*	
	Divertículo	Orificio	Grande*	Lugar(es)
			Pequeño*	
	Fístula			Lugar(es)

*Ver en página 53 Definiciones.

4-3-Lista de términos para la colonoscopía

Los siguientes términos deben ser usados para describir las observaciones hechas durante las exploraciones del tracto gastrointestinal inferior.

Tabla 9: Términos para el colon.

Títulos	**Termino**	**Alteraciones**	**Atributos Añadidos**	**Localización** (El Registro de la

				localización debe ser múltiple para los hallazgos del colon)
Normal	Normal			Lugar(es)
Luz	Dilatada			Lugar(es)
	Estenosis	Aspecto	Extrínseca	Lugar(es)
			Benigna intrínseca	
			Maligna intrínseca	
		Longitud(cm.)		
		Franqueable (sobrepasable)	Si*	
			No*	
	Evidencia de cirugía previa	Tipo	Anastomosis colo-cólica	Lugar(es)
			Anastomosis ileo- cólica	
			Anastomosis colo-anal	
			Anastomosis ileo-anal	
			Colostomia	
		Material de sutura visible	Si	Lugar(es)
			No	
Contenido	Sangre	Aspecto de sangre	Roja	Lugar(es)
			Coágulo	
			Hematina(sangre alterada)	
	Cuerpo Extraño			Lugar(es)
	Parásitos			Lugar(es)
	Exudado			Lugar(es)
	Heces			Lugar(es)
	Prótesis	Tipo	Especificar	Lugar(es)
Mucosa	Patrón vascular	Aspecto	Normal	Lugar(es)
			Aumentado	
			Disminuido	
		Extensión	Localizado	
			Segmentario*	
			Difuso	
	Eritematosa (Hiperémica)	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Segmentaría*	
			Difusa*	
	Congestiva (Edematosa)	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Segmentaría*	
			Difusa*	
	Granular	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Segmentaría*	
			Difusa*	
	Friable	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Segmentaría*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si: Espontáneo	
			Si: Sangrado al contacto	

			No	
	Mucosa Ulcerada	Continuidad	Discontinua	Lugar(es)
			Continua	
		Sangrado	Si	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Petequias	Número	Pocas*	Lugar(es)
			Múltiples*	
	Pseudo-membranas	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Segmentaría*	
			Difusa*	
	Melanosis	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Segmentaría*	
			Difusa*	
Lesiones planas	Angioectasias	Número	Única*	
			Pocas*	
			Múltiples*	
		Tamaño (En este caso el tamaño puede darse en mm para las angiectasias pequeñas)	Pequeñas*	
			Medianas*	
			Grandes*	
		Extensión	Localizada*	
			Parcheada*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
Lesiones protruyentes	Pólipo(s)	Número	Si son menos de 5, especificar Si son mas de 5: Cuantos	Lugar(es)
			Múltiples*	
		Extensión (Este atributo se aplica sólo cuando se describen pólipos múltiples)	Localizada*	
			Segmentaría*	
			Difusa*	
		Tamaño	en mm	
		Pedículo (En caso de pólipos múltiples, esta aplicación debe permitir registrar múltiples entradas)	Sésil	

			Pediculado	
		Sangrado	Si	
			No	
			Estigmas de sangrado	
	Pseudopólipo(s)	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Segmentaría*	
			Difusa*	
	Lipoma	Tamaño	Pequeña*	Lugar(es)
			Mediano*	
			Grande*	
	-	Diámetro	mm	
	Tumor/Masa (Masa se utiliza en lugar de tumor en EEUU)	Tamaño	Pequeña*	Lugar(es)
			Mediano*	
			Grande*	
			Diámetro mayor en mm.	
		Longitud	en cm.	
		Tipo	Submucoso	
			Vegetante	
			Ulcerado	
			Infiltrante	
			Velloso	
		Obstructivo	Parcial	
			Completo	
		Circunferencial	Si	
			No	
		Sangrado	Si: a chorro	
			Si: rezumado	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Papilas anales hipertróficas			
	Hemorroides	Sangrado	Si	
			No	
	Granuloma por sutura	Número	Único	Lugar(es)
			Pocos*	
			Múltiples*	
	Condilomas			
Lesiones excavadas	Erosión .	Número	Única*	Lugar(es)
			Poca*	
			Múltiples*	
		Extensión	Localizada*	
			Segmentaría*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si	

			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Afta	Número	Única*	Lugar(es)
			Pocas*	
			Múltiples*	
		Extensión	Localizada*	
			Segmentaría*	
			Difusa*	
		Sangrado	Si	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Ulcera	Número	Única* (Solitaria)	Lugar(es)
			Pocas*	
			Múltiples*	
		Tamaño	Diámetro mayor en mm.	
		Sangrado	Si: a chorro	
			Si: rezumado	
			No	
		Estigmas de sangrado	Si	
			No	
	Cicatriz	Número	Única*	Lugar(es)
			Múltiples*	
	Divertículo	Número	Único	Lugar(es)
			Pocos*	
			Múltiples*	
		Orificio	Pequeño*	
			Grande*	
	Fístula			Lugar(es)
	Fisura anal (Fisura es el término preferido en lugar de erosión que podría ser confundida con las erosiones del colon)			

*Ver en página 53 Definiciones.

4-4-Lista de términos para la CPRE (ERCP).

Los siguientes términos deben ser usados para describir las observaciones hechas durante las exploraciones de la vía biliar y del conducto pancreático. Se dividen por el lugar anatómico según el área visualizada durante la CPRE(ERCP).

4-4-1-Lista de términos para el duodeno

Los términos utilizados para el duodeno en la Tabla 8 deben ser usados para describir las observaciones hechas en el duodeno.

4-4-2-Lista de términos para la papila mayor.

Los siguientes términos deben ser usados para describir las observaciones hechas durante las exploraciones de la papila mayor. Es útil especificar si la posición de la papila es normal, peridivertícular o intradivertícular.

Tabla 10: Términos para la papila mayor

Títulos	Termino	Alteraciones	Atributos Añadidos	Localización
Normal	Normal			Lugar(Es)
Salida de contenido anómalo	Sangre			Lugar(es)
	Pus			Lugar(es)
	Barro			Lugar(es)
	Cálculo impactado			Lugar(es)
	Cuerpo Extraño			Lugar(es)
	Parásitos			Lugar(es)
	Prótesis			Lugar(es)
	Drenaje			Lugar(es)
Aspecto anómalo	Estenosis	Aspecto	Benigna	Lugar(es)
			Maligna	
	Abombamiento			Lugar(es)
	Congestiva			Lugar(es)
	Lacerado			Lugar(es)
	Tumor/Masa	Tipo	Velloso	Lugar(es)
			Vegetante	
			Infiltrante	
	Evidencia de intervención endoscópica previa	Tipo	Esfinterotomia Biliar	Lugar(es)
			Esfinterotomia: pancreática	
			Esfinterotomia: Biliar y pancreática	
			Precorte	

*Ver en página 53 Definiciones.

4-4-3-Lista de términos para la papila menor.

Los siguientes términos deben ser usados para describir las observaciones hechas durante las exploraciones de la papila menor.

Tabla 11:Términos para la papila menor

Títulos	Termino	Alteraciones	Atributos Añadidos	Localización
Normal	Normal			Lugar(es)

Salida de contenido anómalo	Sangre			Lugar(es)
	Pus			Lugar(es)
	Prótesis			Lugar(es)
	Drenaje			Lugar(es)
Aspecto anómalo	Congestiva			Lugar(es)
	Lacerado			Lugar(es)
	Tumor/Masa	Tipo	Velloso	Lugar(es)
			Vegetante	
			Infiltrante	
	Evidencia de intervención endoscópica previa	Tipo	Esfinterotomia	Lugar(es)
			Precorte	

*Ver en página 53 Definiciones.

4-4-4-Lista de términos para el páncreas.

Los siguientes términos deben ser usados para describir las observaciones hechas durante las exploraciones del páncreas.

Tabla 12:Términos para el páncreas

Títulos	Termino	Alteraciones	Atributos Añadidos	Localización
Normal	Normal			Lugar(es)
Anomalías	Páncreas Divisum	Extensión	Completo	
			Incompleto	
	Irregularidad	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Segmentaría*	
			Difusa*	
	Dilatado	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Segmentaría*	
			Difusa*	
	Rarefacción (Atenuación de ramas)	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Segmentaría*	
			Difusa*	
	Estenosis	Longitud	en mm	Lugar(es)
	Obstrucción	Aspecto	Calculo	Lugar(es)
			Tumor/Masa	
		Grado	Parcial	
			Completo	
	Cálculo	Número	Única*	Lugar(es)
			Múltiples*	
	Cadena de lagos			Lugar(es)
	Extravasación			Lugar(es)
	Fístula			Lugar(es)
	Evidencia de cirugía previa			Lugar(es)
	Prótesis			Lugar(es)

*Ver en página 53 Definiciones.

4-4-5-Lista de términos para la vía biliar

Los siguientes términos deben ser usados para describir las observaciones hechas durante las exploraciones de la vía biliar.

Tabla 13. Términos para la vía biliar

Títulos	Termino	Alteraciones	Atributos Añadidos	Localización
Normal	Normal			Lugar(es)
Anomalías	Unión conducto Cístico (Este término debería usarse sólo para la descripción de una implantación baja del conducto cístico en la vía biliar principal)	Localización desde la papila	Por debajo de 2 cm.	Lugar(es)
			Más de 2 cm.	
	Irregularidad	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Segmentaría*	
			Difusa*	
	Dilatada	Extensión	Preestenótica	Lugar(es)
			Localizada*	
			Segmentaría*	
			Difusa*	
	Rarefacción (Atenuación de ramas)	Extensión	Localizada*	Lugar(es)
			Segmentaría*	
			Difusa*	
	Estenosis	Longitud	en mm	Lugar(es)
		Número	Único*	
			Múltiples*	
		Extensión	Localizada*	
			Segmentaría*	
			Difusa*	
	Compresión Extrínseca (no estenótica)	Tamaño	Larga*	Lugar(es)
			Corta*	
	Obstrucción	Aspecto	Cálculo	Lugar(es)
			Tumor/Masa	
		Grado	Parcial	
			Completa	
	Cálculo	Número	Especificar si menos de 5	Lugar(es)
			Múltiples*	
		Tamaño (Poner aquí el diámetro del cálculo mayor)	en mm	
	Defecto de repleción (otros que cálculos) (Este término nunca debería utilizarse para referirse a cálculos)	Aspecto	Burbujas de aire	Lugar(es)
			Barro biliar	
			Parásitos	
			Tubo en T (Kehr)	
	Prótesis		Especificar	Lugar(es)

	Extravasación			Lugar(es)
	Cavidad	Número	Única*	Lugar(es)
			Múltiples*	
		Diámetro	en mm	
	Fístula		Especificar...	Lugar(es)
	Evidencia de cirugía previa		Colecistectomia	Lugar(es)
			Coledoco-duodenostomia	
			Coledocoenterostomia	
			Colecistoenterostomia	
			Transplante hepático	
	Prótesis		Especificar	Lugar(es)

*Ver en página 59 Definiciones.

4.5 Diagnósticos Adicionales y Procedimientos Terapéuticos.

Los siguientes términos deben ser usados para describir los diagnósticos adicionales y procedimientos terapéuticos realizados durante la endoscopia.

Tabla 14. Términos de diagnóstico adicional y procedimientos terapéuticos

Títulos	Termino	Alteraciones	Atributos Añadidos	Localización
Procedimientos Diagnósticos	Biopsia	Instrumento	Pinza	Lugar(es)
			Asa	
		Método	Fría	
			Caliente	
		Espécimen	Histología	
			Microbiología	
			Test Helicobacter pylori	
	Citología	Lesión	Especificar	Lugar(es)
	Cromoscopia	Tipo	Tinción por spray	Lugar(es)
			Tinción	
		Colorante	Especificar	
	Aspirado de líquidos			Lugar(es)
	Fluoroscopia	Tipo	Especificar	Lugar(es)
	Colangioscopia	Tipo	Especificar	Lugar(es)
	Ultrasonografia endoscópica	Tipo	Especificar utilizando la Terminología adecuada	Lugar(es)
Procedimientos Terapéuticos	Extracción de cuerpo extraño	Tipo		Lugar(es)
	Polipectomia	Instrumento	Pinza	Lugar(es) (En referencia a localización descripción, tamaño o número de pólipos extraídos)
			Asa	
		Método	Fría	
			Caliente	

		Resultado	Completa	
			Incompleta	,
		Recuperación del pólipo	Recuperado No recuperado	
	Esfinterotomía	Precorte	Si	
		Resultado	Satisfactoria	
			In satisfactoria	
	Extracción de cálculos	Resultado	Completa	
			Incompleta	
			Insatisfactoria	
	Litotripsia	Tipo	Especificar...	
		Resultado	Satisfactoria	
			Insatisfactoria	
	Quistostomia	Tipo	Transgástrica	
			Transduodenal	
	Colocación de hilo-guía	Tipo	Especificar	Lugar(es)
		Resultado	Satisfactorio	
			Insatisfactorio	
	Colocación de drenaje/sonda	Tipo	Nasobiliar	
			Nasoquistico	
			Nasoentérico	
			Nasopancreático	
	Prótesis	Resultado	Satisfactorio	
			Insatisfactorio	
	Gastrostomia endoscópica percutánea(PEG)	Tipo	Especificar	
		Forma extracción	Externa	
			Interna	
		Resultado	Satisfactorio	
			Insatisfactorio	
	Dilatación	Tipo	Bujías con guía	Lugar(es)
			Bujías sin guía	
			Balón	
		Tamaño (En French o gauge)		
		Resultado	Satisfactorio	
			Insatisfactorio	
		Lesión	Especificar	
	Inyección	Material inyectado	Especificar	Lugar(es)
		Volumen	Especificar	
		Motivo	Hemostasia	
			Erradicación de varices	
			Destrucción tumoral	
			Depósito de	

			fármacos	
			Tatuaje	
		Resultado	Satisfactorio	
			Insatisfactorio	
	Ligaduras	Tipo	Especificar	Lugar(es)
		Número	Especificar	.
		Resultado	Satisfactorio	
			Insatisfactorio	
	Prótesis	Tipo	Especificar ...	Lugar(es)
		Longitud	en cm o mm	
		Diámetro	en French en mm	
		Resultado	Satisfactorio	
			Insatisfactorio	
	Resección mucosa	Tipo	Especificar	Lugar(es)
		Lesión	Especificar	
		Resultado	Satisfactorio	
			Insatisfactorio	
	Terapéutica Térmica	Tipo	Coagulación	Lugar(es)
			Vaporización	
		Instrumento	Eléctrico monopolar	
			Eléctrico bipolar	
			Láser	
			Argón beam	
		Motivo	Hemostasia	•
			Destrucción tisular	
			Destrucción tumoral	[1]
		Resultado	Satisfactorio	
			Insatisfactorio	
	Terapéutica fotodinámica	Tipo	Especificar	Lugar(es)
		Motivo	Especificar	
		Resultado	Satisfactorio	
			Insatisfactorio	
	Radioterapia Intraluminal	Tipo	Especificar	Lugar(es)
		Motivo	Especificar	
		Resultado	Satisfactorio	
			Insatisfactorio	

4-6-Complicaciones

Los siguientes términos deben ser utilizados para describir las complicaciones.

Tabla 15: Términos para las complicaciones

Complicaciones	Cardiorespiratorias
	Perforación
	Hemorragia

	Pancreatitis
	Infección

5-Motivos para la Endoscopia.

5-1-Ámbito.

Estas listas han sido revisadas por la ASGE, no obstante hay algunas diferencias en si uso entre la comunidad Europea y Estados Unidos. Las listas han sido proporcionada con !a condición de ser comprobadas. En EEUU a menudo se utilizan las indicaciones ej lugar de los motivos para la endoscopia. Una indicación se utiliza para definir el motivo por el que se hace una endoscopia cumpliendo los estándares generales de buena práctica. Puede haber motivos para hacer una endoscopia que no sean indicaciones. Pe ejemplo, un paciente puede querer un seguimiento anual con colonoscopía por cáncer de colorectal, incluso si no hay una historia previa de pólipos o de cáncer colónico familiar. El motivo para la endoscopia es para excluir un tumor, pero esto no es ninguna indicación.

La lista de Indicaciones recomendada por el Comité de la ASGE fue destinada a ser un medio de evaluación de la relevancia y necesidad de una exploración endoscópica. Esta lista ha sido concebida en base a su conveniencia para una exploración individual. Mientras se valoraban los motivos que había detrás de esta decisión, el Comité sintió que era más importante registrar el porqué una exploración concreta había sido encargada más que instruir a los usuarios de cuando una exploración es admisible.

Por tanto "Motivos para" han sido divididos en:

1. Síntomas: que permiten a! usuario registrar los síntomas por los que se solicita la exploración endoscópica. Esto es particularmente importante cuando una enfermedad es difícil de definir.

2. Enfermedades: lista de las enfermedades comunes por las que se solicita una exploración endoscópica. Estas se deben calificar en Presunción..., Por exclusión de..., Para seguimiento de... o Para tratamiento de....

3. Evaluación de: este punto se introdujo en la lista de Motivos de... para permitir el registro de exploraciones realizadas para evaluar el estado de una parte del tracto gastrointestinal antes o después de una intervención quirúrgica, en ausencia de un signo especifico que exija la exploración de este órgano.

4. Diagnóstico por muestra: esto se incluye en Motivos para..., al reconocerse que algunas exploraciones se realizan sólo para obtener una muestra.

La lista propuesta se proporciona para cada tipo de exploración a realizar.

5.2 Motivos para la exploración.

5-2-1-Endoscopia gastrointestinal alta.

Los siguientes términos se deben de utilizar para describir los motivos por los que se realiza una exploración gastrointestinal alta.

Tabla 16: Motivos para la exploración gastrointestinal alta

Síntomas	
Molestias abdominales	

Disfagia	
Hematemesis	
Melena	
Pirosis	
Náusea/Vómito	
Pérdida de peso	
Anemia	
Molestias abdominales	
Enfermedades	**Atributo**
Tumor	Establecido
Enfermedad por reflujo	Exclusión de
Ulcera	Sospecha de
Gastritis	Seguimiento de
Estenosis	Tratamiento de
Sangrado gastrointestinal	
Varices	
Lesiones precancerosas	
Cuerpo Extraño	
Metástasis de origen desconocido	
Evaluación	
Preoperatoria	
Post-quirúrgica	
Cribaje (screening)	
Historia familiar de neoplasia	
Anomalía en procedimiento de imagen	Especificar
Diagnóstico por muestra	Especificar

5-2-2-Endoscopia Gastrointestinal Baja

Los siguientes términos deben ser usados para describir los motivos para la realización de una exploración gastrointestinal baja.

Tabla 17: Motivos para la realización de una exploración Gastrointestinal baja.

Síntomas	
Hematoquecia	
Melenas de origen desconocido	
Diarrea	
Molestias abdominales/dolor	
Modificación del hábito intestinal	
Anemia	
Pérdida de peso	
Enfermedades	**Atributo**
Pólipos	Sospecha de
Cáncer colorectal	Establecido
Obstrucción colonica	Exclusión de
Divertículos	Seguimiento de
Enfermedad inflamatoria intestinal:	Tratamiento de
Enfermedad de Crohn	
Colitis ulcerosa	

Vólvulo	
Angiodisplasia	
Colitis isquémica	
Colitis pseudomembranosa	
Evaluación	
Preoperatoria	
Post-quirúrgica	
Pérdida oculta de sangre	
Cribaje (screening)	
Historia familiar de neoplasia	Especificar
Anomalía en procedimiento de imagen	
Diagnóstico por muestra	Especificar

5-2-3-CPRE (ERCP)

Los siguientes términos deben ser utilizados para describir los motivos para realizar una CPRE (ERCP).

Tabla 18: Motivos para realizar una CPRE (ERCP)

Síntomas	
Ictericia	
Dolor abdominal sospechoso de ser de origen biliar o pancreático	
Anomalías analíticas	
Analítica hepática	
Analítica pancreática	
Anomalía en procedimiento de imagen	Especificar
Enfermedades	**Atributo**
Cálculo conducto biliar	Sospecha de
Litiasis vesicular	Establecido
Pancreatitis aguda	Exclusión de
Pancreatitis crónica	Seguimiento de
Tumor periampular	Tratamiento de
Tumor pancreático/biliar	
Colangitis	
Quiste pancreático o biliar	
Complicación de cirugía previa	
Complicación de intervención previa no quirúrgica	
Obstrucción de prótesis	
Evaluación	
Preoperatoria	
Postoperatoria	
Diagnóstico por muestra	Especificar
Tratamiento	
Esfinterotomía	
Extracción de cálculos	
Prótesis: conductos biliares/ pancreático	Especificar biliar o pancreático
Prótesis: extracción o recambio	Especificar biliar o pancreático
Dilatación	Especificar biliar o pancreático
Drenaje	Especificar biliar o pancreático

Drenaje de quiste	Especificar biliar o pancreático
Hemostásia	

6-Diagnóstico.

6-1-Ámbito

La lista de términos para cada exploración indica el diagnóstico, único o múltiple que el endoscopista cree más probable en base a los hallazgos macroscópicos. Este no es necesariamente el diagnóstico fina!, que tiene en cuenta los hallazgos de cualquier procedimiento adicional tales como biopsia o citología. La lista de diagnóstico ha sido escindida en dos partes: (i)Diagnósticos principales, ordenados por la prevalencia esperada; (II) Otros diagnósticos (más raros), listados alfabéticamente. La decisión de en qué lista aparece un diagnósticos concreto se basa en la frecuencia esperada de este hallazgo en un contexto europeo. Este "diagnóstico" podría ser usado para implementar un campo de "conclusión" dentro de cualquier informe que se genere. Tal conclusión se basaría en una síntesis de todos los hallazgos registrados. Esto es particularmente cierto cuando se describen diversas lesiones, tal como en la colonoscopía de la enfermedad inflamatoria intestinal.

El Comité recomienda también que debería ser posible registrar tanto las conclusiones negativas como las positivas. A menudo es tan importante registrar un hallazgo que no se presenta, como describirlo, por ejemplo, el no encontrar signos de sangrado cuando el paciente acude por una posible hemorragia gastrointestinal. Se sugiere que sea posible que se califique un diagnóstico en "certeza", "sospecha", "probablemente no sea" y "definitivamente excluido".

6.2 Lista de diagnósticos para el tracto gastrointestinal alto.

6-2-1-Esófago.

Los siguientes términos deben ser utilizados para describir los diagnósticos del esófago.

Tabla 19: Lista de diagnósticos del esófago

Diagnóstico principal	Normal	**Atributo**
	Esofagitis por reflujo	Sospecha de
	Varices	Establecido
	Estenosis benigna	Exclusión de
	Tumor maligno	Seguimiento de
	Esófago de Barrett	Tratamiento de
	Ulcera	
Otros diagnósticos	Acalasia	
	Tumor benigno	
	Divertículo	
	Fístula	
	Cuerpo Extraño	
	Hernia de hiato	
	Síndrome de Mallory-Weiss	
	Esofagitis por cándidas	
	Esofagitis sin reflujo	
	Pólipo	
	Aspecto Post-quirúrgico	

	Aspecto post-escleroterapia	
	Cicatriz	
	Anillo de Schatzki	
	Tumor submucoso	

6.2.2 Estómago

Los siguientes términos se utilizaran para describir los diagnósticos del estómago:

Tabla 20: Lista de diagnósticos del estómago

Diagnóstico principal	Normal	**Atributo**
	Gastropatías Erosiva	Sospecha de
	Gastropatía Eritematosa (hiperémica)	Establecido
	Gastropatía Hipertrófica	Exclusión de
	Gastropatía Hemorrágica	Seguimiento de
	Mucosa gástrica atrófica	Tratamiento de
	Sospecha de gastritis (en este caso, las opciones "Sospecha de..." se deben aplicar)	
	Gastropatía de la hipertensión portal	
	Ulcera gástrica	
	Ulcera gástrica sangrante	Además de los atributos generales anotados arriba se puede incluir el tipo de sangrado conforme a la clasificación de Forrest modificada para este diagnóstico: Tipo I A: activa pulsátil Tipo I B: activa rezumado Tipo II A: Vaso visible Tipo II B: material oscuro/coágulo Tipo III: sin estigmas de sangrado
	Ulcera anastomótica	
	Tumor maligno: Especificar si es relevante "carcinoma gástrico"	
	Pólipos	
Otros diagnósticos	Angiectasia	
	Tumor benigno	
	Sangrado de origen desconocido	
	Anomalía vascular de Dieulafoy	
	Divertículo	
	Cáncer gástrico precoz	
	Compresión extrínseca	
	Fístula	
	Cuerpo Extraño	
	Retención gástrica	
	Helicobacter pylori	
	Gastropatía papulosa	

	Parásitos (debe de añadirse una lista en algunos países)	
	Cambios Post-quirúrgicos	
	Cicatriz	
	Tumor submucoso	
	Varices	

6.2.3 Duodeno-

Los siguientes términos deben usarse para describir los diagnósticos del duodeno:

Tabla 21: Lista de diagnósticos del duodeno.

Diagnóstico principal	Normal	**Atributo**
	Duodenopatía Erosiva	Sospecha de
		Establecido
	Duodenopatía Eritematosa (Hiperémica)	
	Duodenopatía Congestiva	Exclusión de
	Duodenopatía Hemorrágica	Seguimiento de
	Ulcera duodenal	Tratamiento de
	Ulcera duodenal sangrante	Además de los atributos generales anotados arriba se puede incluir el tipo de sangrado conforme a la clasificación de Forrest modificada para este diagnóstico: Tipo I A: activa pulsátil Tipo I B: activa rezumado Tipo II A: Vaso visible Tipo II B: material oscuro/coágulo Tipo III: sin estigmas de sangrado
	Deformidad ulcerogénica del duodeno	
Otros diagnósticos	Angiectasia	
	Tumor benigno de origen desconocido	
	Hiperplasia de glándulas de Brunner	
	Enfermedad celíaca	
	Enfermedad de Crohn	
	Divertículo	
	Fístula	
	Tumor maligno	
	Parásitos	
	Pólipo(s)	
	Cambios Post-	

	quirúrgicos	
	Cicatriz	
	Tumor submucoso	
	Otro (Especificar)	

6-3-Lista de diagnósticos de patología gastrointestinal baja

Los siguientes términos deben ser, utilizados para describir los diagnósticos del colon.

Tabla 22: Lista de diagnósticos del colon.

Diagnóstico principal	Normal	**Atributo**
	Pólipo(s)	Sospecha de
	Tumor maligno: Primario	Establecido
	Tumor maligno: Recidiva	Exclusión de
	Tumor maligno: posquirúrgico/anastomotico	Seguimiento de
	Colitis ulcerosa: Inactiva	Tratamiento de
	Colitis ulcerosa: Activa leve	
	Colitis ulcerosa: Activa severa	
	Enfermedad de Crohn: Inactiva	
	Enfermedad de Crohn: Activa leve	
	Enfermedad de Crohn: Activa severa	
	Colitis inespecífica	
	Diverticulosis	
	Diverticulitis	
	Proctitis/colitis por radiación	
	Hemorroides	
Otros diagnósticos	Angioectasia (anomalía vascular)	
	Sangrado de origen desconocido	
	Condiloma	
	Cuerpo Extraño	
	Fístula	
	Ileítis	
	Colitis isquémica	
	Linfoma	
	Melanosis coli	
	Parásitos (debe de añadirse una lista en cada país)	
	Poliposis colónica	
	Neumatosis colónica	
	Cambios Post-quirúrgicos	
	Estenosis postquirúrgica	
	Proctitis	
	Colitis pseudomembranosa	
	Ulcera solitaria	
	Lipoma	
	Otros (Especificar)	

6-4-Lista de diagnósticos de CPRE (ERCP)

6.4.1.Páncreas

Los siguientes términos deben de usarse para describir los diagnósticos del páncreas.

Tabla 23: Lista de diagnósticos del páncreas.

Diagnóstico principal	Normal	**Atributo**
	Pancreatograma fallido	Sospecha de
	Pancreatograma normal	Establecido
	Pancreatitis crónica	Exclusión de
	Tumor de páncreas	Seguimiento de
	Quiste pancreático	Tratamiento de
	Estenosis papilar	
	Tumor de la papila (Ampuloma)	
Otros diagnósticos	Unión bilio- pancreática anómala	
	Páncreas anular	
	Páncreas Divisum	
	Fístula del conducto pancreático	
	Cálculos pancreáticos	
	Parásitos	
	Otros (Especificar)	

6.4.2. Vía Biliar

Los siguientes términos deben ser utilizados para describir los diagnósticos dé la vía biliar:

Tabla 24: Lista de diagnósticos de la vía biliar.

Diagnóstico principal	Normal	**Atributo**
	Colangiografía fallida	Sospecha de
	Colangiografía normal	Establecido
	Coíangiografía normal postcolecistectomia	Exclusión de
	Colangiografía normal postesfínterotomia	Seguimiento de
	Colélitiasis	Tratamiento de
	Colédocolitiasis	
	Colecistolitiasis	
	Litiasis hepática	
	Litiasis conducto cístico	
	Litiasis muñón cístico	
	Síndrome de Mirizzi	
	Tumor vía biliar	
	Tumor hepático común	
	Tumor de Klatzkin	
	Tumor de vesícula biliar	
	Estenosis de la papila	
	Tumor de la papila (Ampuloma)	
	Prótesis ocluida	
Otros diagnósticos	Unión bilio pancreática anómala	
	Fístula biliar	

	Obstrucción biliar	
	Fuga biliar	
	Estenosis biliar	
	Enfermedad de Caroli	
	Quiste coledocal	
	Coledococele	
	Cirrosis	
	Hemobília	
	Estenosis de la papila	
	Parásitos	
	Colangitis esclerosante	
	Síndrome del sumidero	
	Colangitis supurativa	
	Tumor de la vesícula	
	Otros (Especificar)	

7-Bibliografía

1. Maratka, Z. Terminology, definitions and diagnostic criteria in digestive endoscopy. Sean J Gastroenterol 1984;19(suppl 103):1-74.

2. American Society for Gastrointestinal Endoscopy Computer Syllabus, ASGE Computer Committee, Manchester, Ma, May, 1984.

3. Kruss, DM. The ASGE datábase: computers in the endoscopy unit. Endose Rev 1987;4:64-70.

4. Maratka Z. Databases for gastrointestinal endoscopy [letter]. Gastrointest Endose 1992;38(3):395-396.

5. Maratka Z, Schapiro M. Terminology and its application to computer-aided data proces-sing in digestive endoscopy. J Clin Gastroenterol 1990;12(2):130-131.

6. Maratka Z. Terminology, Definitions and Diagnostic Criteria in Digestive Endoscopy, Third Edition. Bad Homburg: Normed Verlag, 1994.

7. Crespi M, Delvaux M, Schapiro M, Venables C, Zweibel F. Minimal standards for a computerized endoscopic datábase. Am J Castro 1994;89:S144-S153.

8. Crespi M, Delvaux M, Schapiro M, Venables C, Zwiebel FM. Working Party Report by the Committee for Minimal Standards of Terminology and Documentation in Digestive Endoscopy of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy. Minimal standards for a computerized endoscopic datábase. Am. J. Gastroenterol. 1996; 91: 191-216.

8-Historia de las revisiones

Autor	Número de la revisión	Fecha	Lugar
ESGE	1.0	01-05-1995	Los Angeles, CA
LY Korman	1.0Q	21-01-1998	Washington DC
ESGE/ASGE	2.0a	06-03-1998	Barcelona, España

ESGE/ASGE	2.0b	02-05-1998	Roma, Italia
M. Delvaux - LY Korman	2.0c	06-06-1998	Toulouse, Francia Washington DC
M. Delvaux LY Korman	2.0d	14-07-1998	Toulouse, Francia Washington DC
- M. Delvaux	2.0e	06-03-1999	Toulose, Francia

Definiciones

Procedencia: OMED: Committee for Terminology Standardization and Data Processing

Términos para el Esófago

Luz

Compresión extrínseca (sólo en ausencia de estenosis):

- Tamaño:
  - Pequeña: No involucra toda la pared del segmento considerado. Se puede definir como de menos de 3 cm. de diámetro, pero el endoscopista deberá referenciarlo en comparación con las estructuras que lo rodean.
  - Largo (extenso): Distorsión que involucra toda la pared del órgano: más de 3 cm..

Hernia del Hiato:

- Tamaño/Volumen:
  - *Pequeña:* Deslizamiento limitado del estómago hacia el tórax. Menos de 5cm.
  - *Mediana:* Es de tamaño intermedio. Debe definirse en comparación con las estructuras que lo rodean. Entre 5-10 cm.
  - *Grande:* Deslizamiento de una gran parte del fundus gástrico dentro del tórax. Se ve mejor ante la ausencia de los movimientos respiratorios. Más de 10 cm..

Mucosa

Eritematosa (Hiperémica); Candidiasis; Mucosa esclerosada (fibrosis):

- Extensión:
  - *Localizada:* Lesión limitada a un área muy restringida del órgano, vista sin mover la punta del endoscopio.
  - *Parcheada:* Lesión extendida a varias áreas, pero separadas por mucosa normal.
  - *Difusa:* Lesión que se extiende en totalidad, sin zonas de mucosa norma.

Esofagitis(Clasificación de SAVARY-MILLER - Sacand. J. GastroenteroL 1984, 19:26-44):

- Grado:
  - *Grado* I*:* Bandas o franjas rojas o erosiones con exudado blanquecino, no confluentes y que no toman toda la circunferencia del órgano.
  - Grado II: Bandas rojas o erosiones con exudados confluentes, pero no toman toda la circunferencia del órgano.
  - *Grado* III*:* Erosiones que confluyen con exudado que toman toda la circunferencia del órgano.
  - *Grado* IV*:* Úlcera/s, estenosis pépticas o metaplasia de Barrett.

Lesiones Planas

Mucosa gástrica ectópica y Placa:

- Número:
    - Única: Una sola lesión.
    - Múltiples: Más de una lesión.

Lesiones Protruyentes

Nódulo: Protrusión de mucosa generalmente circular y de hasta 2-3 mm de diámetro.

- Número:
    - Única: Una sola lesión.
    - Pocas: Entre 2 (dos) y 5 (cinco) lesiones.
    - Muchas: Más de 5 (cinco) lesiones.

Tumor-Masa:

- Medida: Es el volumen-extensión de la lesión, en comparación con el aspecto endoscópico de indicadores anatómicos circundantes tomados como referencia. Es considerada de acuerdo a la superficie de la misma y su elevación en la luz del órgano.
    - Pequeño: Lesión que abarca un área restringida de la mucosa observada desde una distancia cercana, sin mover la punta del endoscopio.
    - Mediana: Lesión que involucra el segmento total del órgano tomando como referencia un punto fijo de la misma.
    - Grande: Lesión amplia que toma una gran superficie del órgano y no puede ser totalmente vista sin mover la punta del endoscopio.
- Tipo:
    - Submucoso: Protrusión de variados aspectos revestido por mucosa normal.
    - Vegetante: Protrusión exofítica de aspecto irregular.
    - Ulcerado: Protrusión con defecto de la superficie

Várices: (Clasificaciones mayoritariamente utilizadas en la literatura, ej.: Gastroenterology 1967; 52:810-818: Gastroenterology 1990, 98:156-162)

- Grado
    - Grado I: Várices planas que desaparecen con la insuflación de la luz del
    - órgano.
    - Grado II: Várices permanentemente visibles en la luz del órgano, pero
    - que se presentan en bandas separadas.
    - Grado III: Várices extremadamente protruyentes en la luz del órgano que
    - aparecen como casi ocluyendo a la misma sin insuflación de aire.

Términos para el Estómago

Contenido

Fluidos: Presencia de material líquido en el estómago, que puede ser jugo gástrico o de otro origen, excepto sangre

- Aspecto:
    - Claro: Presencia de líquido transparente como el agua.
    - Excesivo: Presencia de importante cantidad de líquido, mayor al residuo normal de jugo gástrico que se encuentra en el estómago de sujetos en ayunas.
    - Bilioso: Presencia de líquido amarillo, verde o marrón que puede corresponder a bilis refluida desde el duodeno.

Mucosa

Eritematosa (Hiperémica):

- Extensión:
  - Localizada: Lesión limitada a un área muy restringida del órgano, vista sin mover la punta del endoscopio.
  - Parcheada: Lesión extendida a varias áreas, pero separadas por mucosa normal.
  - A tiras: Lesiones de áreas rojas dispuestas en franjas o tiras longitudinales.
  - Difusa: Lesión que se extiende en totalidad, sin zonas de mucosa norma.

Petequias: Puntos rojos o manchas rojas causadas por hemorragias capilares subepitelíales.

- Cantidad:
  - Única: una sola lesión.
  - Pocas: 2 (dos) a 5 (cinco) lesiones.
  - Múltiples: más de 5 (cinco) lesiones.

Lesiones Protruyentes

Pliegues engrosados: Pliegues gástricos que aparecen más engrosados y que no desaparecen con la insuflación.

- Tipo:
  - Grueso: Incremento de la amplitud y altura de los pliegues gástricos, vistos permanentemente y de forma regular.
  - Gigante: Marcado incremento de los pliegues gástricos, de aspecto tortuosos e indurados.

Tumor/masa:

- Tipo:
  - Submucoso: Protrusión de variados aspectos revestido por mucosa normal.
  - Vegetante: Protrusión exofítica de aspecto irregular.
  - Ulcerado: Protrusión con defecto de la superficie mucosa.
  - Infiltrante: Área de la pared mucosa engrosada, la cual es generalmente firme indurada y no plegable. La superficie mucosa puede ser normal o anormal.

Lesiones Excavadas

Ulcera:

- Forma:
  - Superficial: Lesión excavada que no involucra profundamente la pared del órgano.
  - Crateriforme: Depresión marcada de la parte principal de la lesión, que parece estar por debajo del plano mucoso. Presenta frecuentemente forma circular.
  - Lineal: Defecto largo y estrecho que se asemeja a una línea recta.

Cicatriz: Depresión o deformación generalmente limitada de la mucosa que puede ser consecuencia de un tratamiento previo, quirúrgico o endoscópico o espontánea por la curación de una lesión observada en ésa localización.

- Número:
  - Única: una sola lesión.
  - Múltiple: más de una lesión.

Términos para el Duodeno y Yeyuno

Lesiones Protruyentes

Tumor / Masa :

- Tamaño:
  - Pequeño: Lesión que abarca un área restringida de la mucosa observada desde una distancia cercana, sin mover la punta del endoscopio.
  - Mediano: Lesión que involucra el segmento total del órgano, tomando como referencia un punto fijo de la misma,
  - Grande: Lesión amplia que toma una gran superficie del órgano y no puede ser totalmente vista sin mover la punta del endoscopio
- Tipo:
  - Submucoso: Protrusión de variados aspectos revestido por mucosa normal.
  - Vegetante: Protrusión exofítica de aspecto irregular.
  - Ulcerado: Protrusión con defecto de la superficie mucosa.
  - Infiltrante: Área de la pared mucosa engrosada, la cual es generalmente firme indurada y no plegable. La superficie mucosa puede ser normal o anormal.
  - Velloso: Protrusión sésil generalmente de considerable volumen, pálida y cubierta en gran parte por formaciones alargadas como hojas o frondas

Lesiones Excavadas

Divertículo:

- Orificio:
  - Grande: Presenta orificio o boca amplia que abarca todo el saco y permite ver toda la superficie del mismo.
  - Pequeño: Presenta orificio o boca pequeña que no permite ver completamente el saco del mismo.

Términos para la Colonoscopía (recto y colon)

Luz

Estenosis: Disminución del calibre de la luz o lumen del órgano o de un esfínter que aparece como permanente.

- Franqueable (sobrepasable): Este atributo determina si la estenosis puede atravesarse o no con el endoscopio. Representa una medida cualitativa del grado de estenosis y es dependiente del diámetro del instrumento utilizado.
  - Si: está habilitado para poder ser pasado espontáneamente con el endoscopio.
  - No: Imposibilidad de poder pasar con el endoscopio a través de la estenosis.

Mucosa

Patrón vascular, Eritematosa (hiperémica), Congestiva (edematosa), Granular, Friable: Pseudomembranas, Melanosis:

- Extensión:
  - Localizada: Lesión limitada a un área muy restringida del órgano, vista sin mover la punta del endoscopio.
  - Segmentada: Lesión que involucra una parte limitada del recto o colon que puede ser reconocida o delimitada por signos bien definidos.
  - Difusa: Lesión que se extiende en totalidad, sin zonas de mucosa normal.

Mucosa ulcerada: Ulceraciones extendidas de la mucosa tales que no permite visualizar el epitelio normal. La mucosa aparece desprovista de su capa superficial. Esto se diferencia de las ulceraciones múltiples donde hay áreas de epitelio normal.

- Continuidad:
    - Discontinua: Lesión que involucra una parte limitada de la mucosa que puede ser vista desde un punto fijo del endoscopio.
    - Continua: Lesión que involucra toda la superficie observada.

Lesiones Protruyentes

Pólipo:

- Número:
    - Si son menos de 5 (cinco): especificar lugar.
    - Si son más de 5 (cinco):Cuántos: Presencia de una cantidad de pólipos que pueden ser contados, distribuidos en un área delimitada de la superficie mucosa. Generalmente de 5 (cinco) a 15 (quince).
    - Múltiples: Presencia de una gran cantidad de pólipos (demasiados para poder ser contados) distribuidos en un área extensa de la superficie mucosa y que ocupan la totalidad de un segmento del órgano.

Lipoma: Tumor sub-mucoso formado por tejido adiposo, que le da un color amarillento observado a través de la mucosa normal que lo recubre.

- Tamaño:
    - Pequeño: Mide menos de 5 mm.
    - Mediano: Mide entre 5 y 20 mm.
    - Grande: Mide más de 20 mm.

Tumor/ Masa:

- Tamaño:
    - Pequeño: Lesión que abarca un área restringida de la mucosa observada desde una distancia cercana, sin mover la punta del endoscopio.
    - Mediano: Lesión que involucra el segmento total del órgano, tomando como referencia un punto fijo de la misma
    - Grande: Lesión amplia que toma una gran superficie del órgano y no puede ser totalmente vista sin mover la punta del endoscopio.
- Tipo:
    - Submucoso: Protrusión de variados aspectos revestido por mucosa normal.
    - Vegetante: Protrusión exofítica de aspecto irregular.
    - Ulcerado: Protrusión con defecto de la superficie mucosa.
    - Infiltrante: Área de la pared mucosa engrosada, la cual es generalmente firme indurada y no plegable. La superficie mucosa puede ser normal o anormal.
    - Velloso: Protrusión sésil generalmente de considerable volumen, pálida y cubierta en gran parte por formaciones alargadas como hojas o frondas.

Lesiones Excavadas

Divertículo:

- Número:
    - Unico: Divertículo único visto generalmente solo en el recto, sobre un pliegue mucoso prominente.
    - Pocos: Presencia de un limitado número de divertículos (de 2 a 5) distribuidos en un área de la superficie mucosa.
    - Múltiples: Presencia de una gran cantidad de diverticulos (más de 5) distribuidos sobre una amplia zona de la superficie mucosa.
- Orificio:
    - Pequeño: Orificio o boca pequeña desde su borde luminar, quo puede ser

- estimado en hasta 4 mm.
- Grande: Su boca u orificio es mayor de 4 mm.

Términos para Papila Mayor y Menor

Tumor / Masa:

- Tipo:
  - Velloso: Protrusión sésil generalmente de considerable volumen, pálida y cubierta en gran parte por formaciones alargadas como hojas frondas.
  - Vegetante: Protrusión exofítica de aspecto irregular.
  - Infiltrante: Área de la pared mucosa engrosada, la cual es generalmente firme indurada y no plegable. La superficie mucosa puede ser normal o anormal.

Términos para el Páncreas

Irregularidad: Forma de los conductos pancreáticos dístales que no muestran una disminución progresiva de su calibre, sino un aspecto irregular de los mismos, con segmentos estenosados y alargados.
Rarefacción: Disminución del número de divisiones de los conductos pancreáticos o ausencia de ramificación de los mismos.

Términos para la Vía Biliar

Anomalías

Estenosis: es el estrechamiento fijo de la luz de un conducto.

- Número:
  - Único: presencia de una sola estenosis segmentaría
  - Múltiples: presencia de más de una estenosis en el conducto

Compresión extrínseca: (no estenótica) distorsión de la luz de un conducto con preservación de su contorno normal por proceso externo al mismo.

- Tamaño: indica la longitud del segmento de la impresión o compresión, como así también el volumen de la misma (puede ser un cálculo del conducto cístico)
  - Larga: el volumen de la protrusión involucra un segmento completo del
  - conducto biliar.
  - Corta: el volumen de lo protruído está limitado a un segmento bien

Cavidad: Colección del medio de contraste localizada y bien delimitada.

- Número:
  - Unica: Una sola.
  - Múltiples: Más de una.

Términos de Diagnósticos Endoscópicos

Atributos de Diagnósticos:

- Sospecha de: Presencia de condiciones particulares o enfermedad, indicados por los hallazgos efectuados durante el procedimiento, aunque la interpretación de los mismos sea cuestionable.
- Establecido: Cuando una afección o enfermedad está diagnosticada con certeza por los hallazgos endoscópicos típicos que la evidencian.

- Exclusión de: Cuando una enfermedad o afección puede ser definitivamente descartada por los hallazgos del examen endoscópico.
- Seguimiento de: Estado en el cual la endoscopía fue realizada para caracterizar la evolución de la enfermedad o afección y no mostró ningún patrón anormal o cambio de los hallazgos endoscópicos anteriores.
- Tratamiento de: Tratamiento endoscópico de una enfermedad realizada durante el examen.